

Spezifikation MIND 7.1 und DIVI-Notfalleinsatzprotokoll 7.1

Das Dokument gliedert sich in folgende Abschnitte:

1. Vorwort und wichtige Hinweise zur Anwendung dieser Spezifikation
2. Datenfelder MIND (inklusive Plausibilitäten und Abhängigkeiten)
3. Codes MIND
4. Exporthinweise MIND
5. Datenfelder komplett (inklusive Plausibilitäten und Abhängigkeiten)
6. Codes DIVI

1. Vorwort und wichtige Hinweise zur Anwendung dieser Spezifikation

Grundsätzlich verfolgen das DIVI-Notfalleinsatzprotokoll und der Minimalen Notfalldatensatz (MIND) gemeinsame, teilweise jedoch auch unterschiedliche Zielsetzungen: In Bezug auf die externe Qualitätssicherung soll der MIND insbesondere auch einen standortübergreifenden Datenvergleich durch den Datenexport eines einheitlichen, pseudonymisierten Datensatzes erlauben, während beim DIVI-Notfalleinsatzprotokoll andere Punkte wie z. B. eine vollständige, patientenbezogene, rechtssichere Dokumentation im Vordergrund stehen.

Die Datenfelder beider Datensätze stimmen daher nicht vollständig überein: Ein Großteil der Datenfelder wird in identischer Form in beiden Datensätzen verwendet. Nur wenige Datenfelder sind ausschließlich Bestandteil des MIND, umgekehrt sind aber zahlreiche weitere Datenfelder nur für das DIVI-Notfalleinsatzprotokoll relevant und für den MIND nicht erforderlich.

Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert. Dadurch wird die Zuordnung der einzelnen Datenfelder zu MIND und DIVI-Notfalleinsatzprotokoll nachvollziehbar und die für den qualitätssicherungsrelevanten MIND erforderlichen Inhalte und Exporthinweise können insbesondere für die Hersteller der präklinischen digitalen Dokumentationssysteme klar abgegrenzt werden. **Für die MIND-Dokumentation und den MIND-Export sind die Kapitel 1 bis 3 maßgeblich. Hersteller und Nutzer, die sich mit dem Thema MIND-Dokumentation und -Export befassen möchten, müssen hierfür diese ersten drei Kapitel beachten.**

Das Kapitel 4 beschreibt den harmonisierten Gesamtdatensatz. Ein eigenständiger Datensatz nur für das DIVI-Notfalleinsatzprotokoll existiert nicht, da sich nur wenige Felder vom Gesamtdatensatz unterscheiden. Das Kapitel 4 umfasst daher sowohl die MIND-Datenfelder, als auch zusätzlich die für das DIVI-Notfalleinsatzprotokoll erforderlichen Inhalte.

Datenfelder, die ausschließlich für das DIVI-Notfalleinsatzprotokoll relevant sind und über den MIND hinausgehen, sind im Kapitel 5 separat aufgelistet und im Kapitel 4 durch rote Feldbezeichnungen gekennzeichnet. **Da diese Felder teilweise personenidentifizierende Merkmale enthalten können, dürfen diese für einen MIND-Export keinesfalls verwendet werden.** Übereinstimmende Datenfelder werden nicht gesondert markiert. Das Kapitel 5 beinhaltet vom MIND abweichende Felder, die ausschließlich für das DIVI-Notfalleinsatzprotokoll Gültigkeit haben.

Die vollständige Definition der Datenfelder für den MIND sowie den Gesamtdatensatz ist jeweils in den Kapiteln „Datenfelder MIND“ bzw. „Datenfelder komplett“ enthalten. Sofern Datenfelder über Codes spezifiziert werden, sind diese in den Kapiteln „Codes MIND“ bzw. „Codes DIVI“ beschrieben.

Im MIND werden Pflichtfelder von optionalen Feldern unterschieden. Bei Pflichtfeldern wird im Datensatz immer ein gültiger Eintrag, entsprechend der in der Spalte „Bezeichnung Merkmal Ausprägung“ definierten Feldinhalte, erwartet. Ein Datensatz kann nicht abgeschlossen und exportiert werden, wenn nicht alle Pflichtfelder mit einem gültigen Eintrag versehen sind. Bei den Pflichtfeldern werden zwei unterschiedliche Pflichtbedingungen unterschieden: Generelle Pflichtfelder sind immer und ohne weitere Abhängigkeiten für jeden Datensatz Pflicht. Dies kann für ein einzelnes Datenfeld oder für ein gesamtes Kapitel gelten, sie sind in der Spalte Pflicht durch ein "Ja" gekennzeichnet. Pflichtfelder, die in Abhängigkeit der Inhalte anderer Felder zur Pflicht werden, sind in der Spalte Pflicht durch "siehe Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten" gekennzeichnet, die Abhängigkeiten selbst sind jeweils in der korrespondierenden Zelle der Spalte "Hinweise/Plausibilitäten/ Abhängigkeiten" definiert.

Für den Export müssen alle MIND-Felder mit Inhalten versehen sein. Wurde in einem optionalen Feld ein Inhalt dokumentiert, der einem im Datensatz definierten Feldinhalt entspricht und damit XSD-konform ist, muss dieser Inhalt entsprechend exportiert werden. Leere optionale Felder, bei denen der Nutzer keinen Wert eingetragen hat, müssen mit dem technischen Default (letzte Spalte im Kapitel Datenfelder_MIND) befüllt werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass ein vom Nutzer eingetragener Inhalt nicht durch den technischen Default überschrieben wird.

Die technischen Defaults dürfen nicht in Felder eingetragen werden, für die eine Pflichtbedingung formuliert ist.

Die Spalte „Bezeichnung Merkmal Ausprägung“ beinhaltet entweder spezifische, darin hinterlegte Felddarstellungen oder verweist auf die korrespondierenden Einträge im passenden Kapitel Codes.

Die Spalte „Erläuterungen“ beinhaltet inhaltliche Klarstellungen, welche Inhalte/Codes für bestimmte Situationen zutreffend sind oder umschreibt, welche Bedingungen dazu führen, dass ein optionales Feld verpflichtend wird.

Die Spalte „Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten“ beschreibt Abhängigkeiten einzelner Felder untereinander, definiert die exakten Voraussetzungen, die optionale Felder zu Pflichtfeldern machen oder definiert Plausibilitäten, die für den MIND-Export zwingend beachtet und eingehalten werden müssen. Idealerweise werden diese Plausibilitäten bereits in die Primärdokumentationssysteme integriert, so dass bereits bei der Erstellung der Notfalldokumentation unzulässige Kombinationen für die Dokumentation nicht zur Auswahl stehen.

Das Kapitel Exporthinweise MIND weist einerseits auf Besonderheiten für das Bundesland Baden-Württemberg hin, wo seit vielen Jahren ein System der externen Qualitätssicherung für den Rettungsdienst auf Basis eines spezifikationskonformen MIND-Exportes etabliert ist und andererseits auf Besonderheiten, die beim Export des MIND generell beachtet werden müssen.

Beide Datensätze beinhalten bei den Befunden und Messwerten jeweils nur die ersten oder die letzten im Einsatzverlauf erhobenen Befunde und Messwerte. Für die präklinische Dokumentation sind natürlich auch Befunde oder Messwerte von Bedeutung, die im Verlauf des notfallmedizinischen Einsatzes erhoben werden und sollten entsprechend auch in den präklinischen Dokumentationssystemen dokumentiert werden können. Diese Befunde und Messwerte im Einsatzverlauf sind jedoch weder Bestandteil des MIND noch des DIVI-Notfalleinsatzprotokoll-Datensatzes.

Die Spezifikation für MIND und DIVI-Notfalleinsatzprotokoll wird durch eine fortlaufende Versionsnummer (7.0, 7.1,...) gekennzeichnet. Eine Änderung der Versionierung erfolgt bei größeren, insbesondere qualitativen inhaltlichen Anpassungen, die Auswirkungen auf den jeweiligen Datensatz oder den Export mit sich bringen. Zusätzlich ist jede Version mit einer Release-Nummer versehen sowie dem Datum, an welchem das Release geändert wurde. Eine Änderung der Release-Nummer erfolgt bei kleineren Anpassungen, insbesondere bei Beseitigung inhaltlicher, orthographischer oder sonstiger Korrekturen, die keine Auswirkungen auf den Datensatz oder den Export ausüben. Die aktuell gültige Fassung der Spezifikation wird jeweils aus der Kombination von Versionsnummer und Release-Nummer angezeigt. Diese Systematik gilt entsprechend für die korrespondierende XSD-Datei.

2. Datenfelder MIND (inklusive Plausibilitäten und Abhängigkeiten)

MINIMALER NOTFALLDATENSATZ MIND 7.1						Release 1: 28.08.2026	
Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach/ Mehrfach E/M	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Kapitel: Standortdaten						Dieses Kapitel ist immer Pflicht	
Protokolltyp	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Typ des verwendeten Protokolls: • NA für Notarztdokumentation • RD für Rettungsdienstdokumentation Sollte in Stammdaten fest dem Rettungsmittel/Personal zugewiesen werden. Beim Wechsel von Dokumentations-Pads zwischen Fahrzeugen muss unbedingt darauf geachtet werden, dass das korrekte Rettungsmittel mit der ihm zugeordneten Projekt-ID und der richtige Protokolltyp ausgewählt sind.	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen z.B. ProjektID, Rettungsmitteltyp, Einsatzort, Qualifikation Personal.	
Standortkennung	Nein	E	Anteiliger Gemeindeclüssel des RM-Standortes BL-LK (Bundesland/Landes-Rettungswache; Bundesland und Landkreis jeweils nach Vorgaben des Gemeindeclüssels) Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Anteiliger Gemeindeclüssel des Rettungsmittel-Standortes.		-2
ProjektID	Ja	E	ProjektID	NA + RD	Standortspezifische Nummer, die von einer zentralen Stelle vergeben und verwaltet wird. Standortverantwortliche sind aufgefordert, sich dort um eine ID-Zuteilung zu bemühen. Einmalig in Stammdaten einzupflegen.	Prüfung auf Plausibilität, z.B. Leitstelle, Einsatzort, Rettungsmitteltyp, Protokolltyp	
Leitstelle	Ja	E	Landkreisnummer der Heimatleitstelle (z.B. S für Stuttgart, OG für Offenburg)	NA + RD	Für einen Standort immer konstant und sollte automatisiert beim Export zugeordnet werden. Einmalig in Stammdaten einzupflegen.	Prüfung auf Plausibilität, z.B. ProjektID und Leitstelle	
Softwarekennung	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Kennung des Dokumentationssystems, des Rettungsmittels und der Software-Version	NA+RD	Identifikation des Dokumentationssystems und der Software-Version, mit der die Einsatzdaten erzeugt wurden.	Pflichtfeld in BW	-2
Kapitel: Rettungsnotschlüsseldaten						Dieses Kapitel ist immer Pflicht	
Primärschlüssel	Ja	E	eindeutiger Primärschlüssel für alle Fälle pro Jahr Zeichenläng 20	NA + RD	Innerhalb eines Leitstellenbereiches darf in einem Kalenderjahr kein Primärschlüssel mehrfach vergeben werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass im NA-Protokoll die NA-Auftragsnummer und im RD-Protokoll die RD-Auftragsnummer verwendet wird! Bei mehreren Patienten in einem Einsatz, soll von der "Heimatleitstelle" für jeden Patienten eine separate Auftragsnummer zugewiesen werden. Diese ist ggf. anzufordern. Dort wo dies leitstellen-labrechnungsgemäß nicht möglich ist, soll der Primärschlüssel im jeweiligen Datensatz durch ein eindeutiges Suffix gekennzeichnet werden (bspw. Auftragsnummer der Leitstelle ergänzt mit -01 bis -99 oder mit -A bis -Z)		
Einsatzort	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Art des RD-Einsatzes/Notarzteinsatzes Für die Auswahl des zutreffenden Codes ist der Status zum Zeitpunkt der Alarmierung des dokumentierenden Rettungsmittels durch die Leitstelle maßgeblich. (d.h. in einem NA-Protokoll dürfen unter Einsatzort nur Ausprägungen mit dem Inhalt "mit (physisch anwesendem) NA" dokumentiert werden, auch wenn der NA nachgefordert wurde und die primäre Alarmierung des RTW ohne NA erfolgte. Im RD-Protokoll dürfen - sofern bei Alarmierung des RTW (noch) keine Alarmierung eines NATNA erfolgt ist - unter Einsatzort nur Ausprägungen mit dem Inhalt "ohne NA" dokumentiert werden, auch wenn es später zu einer NA-Nachforderung kam.) Einsatzorten "mit (physisch anwesendem) NA" (01, 03, 05, 07) bzw. "mit...TNA" (02, 03, 06, 07) sind immer dann auszuwählen, wenn bis zum Zeitpunkt der Alarmierung des dokumentierenden RM ein NA oder ein TNA ebenfalls alarmiert wurden. Dienstreife und Pausen sind organisatorische Einsatzarten, die in keinem Bezug zu einem beabsichtigten oder tatsächlichen Patientenkontakt stehen (beispielsweise Fahrt in die RD-Werkstatt). Ein Materialtransport, für den ein Patientenbezug hergestellt werden kann (z.B. Transport eines Inkubators durch einen RTW zu einem anderen Einsatz) ist nicht mit Dienstreife zu kodieren. Wenn ein RTW von der Leitstelle einen Krankentransportauftrag erhalten hat, ist als Einsatzort Krankentransport auszuwählen.	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Wenn Protokolltyp NA, dann ist EinsatzArt GLEICH (04 ODER 06 ODER 10) unzulässig.	
Gemeindeclüssel	Nein	E	Anteiliger Gemeindeclüssel des Einsatzortes Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Quelle ist das Statistische Bundesamt. Der Anteiliger Gemeindeclüssel (AGS) ist ein 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen)		-2
Postleitzahl	Nein	E	Postleitzahl des Einsatzortes Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	PLZ des Einsatzortes - diese ist bei Einsätzen am Wohnort des Patienten zumeist der Versichertenkarte zu entnehmen.		-2
GeoEinsatzort	Nein	E	Geokoordinaten des Einsatzortes GFS-Geo-Koordinat im Decimalformat (WGS 84)	NA + RD	Die Koordinaten werden in der Reihenfolge Breitengrad, Längengrad mit Komma getrennt angegeben. Format: 99.999999;99.999999		-2
EinsatzortTyp	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Beschreibung des Einsatzortes. Pflicht, außer für Dienstreifen und Pauseneinsätze	Pflicht wenn: EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	-2

Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
RDTransport	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Welches Rettungsmittel hat den überwiegenden Anteil des Transports des Patienten (hinsichtlich der Transportbreite) durchgeführt? "Transport durch NAW" ist nur auszuwählen, wenn es sich bei dem RM von vornherein um einen NAW gehandelt hat (ein RTW, bei dem der NA den Transport begleitet, bleibt ein RTW) Bei gemeinsamem Einsatz von RTW und NA identische Dokumentation in RD- und NA-Protokoll	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. • Bei Auswahl 01 wird KeinTranspMIPat zum Pflichtfeld • Bei Auswahl 02 wird KeinTranspOhnePat zum Pflichtfeld Pflicht wenn: EinsatzArt NICHT (11 ODER 12) Wenn EinsatzArt GLEICH (11 ODER 12), sind sämtliche Inhalte in RDTransport außer -2 unzulässig.	-2
AerztBegleit	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	M	Ärztliche Begleitung Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Wurde der Transport ärztlich begleitet? Wenn ja, von wem? Pflicht für NA- und RD-Protokolle bei Einsätzen mit durchgeführten Transport Bei gemeinsamem Einsatz von RTW und NA identische Dokumentation in RD- und NA-Protokoll	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Pflicht wenn: RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) Kombinationen mit 00 sind unzulässig.	-2
NotarztNachgefordert	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Physisch anwesender Notarzt wurde nachgefordert Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Betrifft nur die Nachforderung eines physisch anwesenden Notarztes (nicht eines Telenotarztes). NA: Wurden Sie nachgefordert? RD: Haben Sie einen Notarzt nachgefordert? Falls unbekannt "nein" dokumentieren Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseneinsätze wenn bei Protokolltyp RD eine Einsatzart ausgewählt wurde, die eine primäre Alarmierung eines (physisch anwesenden) NA zum Ausdruck bringt (01, 03, 05, oder 07) ist die Dokumentation NotarztNachgefordert-ja unzulässig.	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Pflicht wenn: EinsatzArt NICHT (11 ODER 12) Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND EinsatzArt GLEICH (01 ODER 03 ODER 05 ODER 07), dann ist NotarztNachgefordert = 01 unzulässig.	-2
TNANachgefordert	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Telenotarzt wurde nachgefordert Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Betrifft nur die Nachforderung eines Telenotarztes (nicht eines physisch anwesenden Notarztes). NA/RD: Haben Sie einen TNA nachgefordert? Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseneinsätze wenn bei Protokolltyp RD eine Einsatzart ausgewählt wurde, die eine primäre Alarmierung eines TNA zum Ausdruck bringt (02, 03, 06, oder 07) ist die Dokumentation TNANachgefordert-ja unzulässig. Pflicht für Einsätze ohne Transport trotz Patientenkontakt	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Pflicht wenn: EinsatzArt NICHT (11 ODER 12) Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 03 ODER 06 ODER 07), dann ist TNANachgefordert = 01 unzulässig.	-2
KeinTranspMIPat	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Grund für Einsatz ohne Transport trotz Patientenkontakt Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	nur für Einsätze ohne Transport, aber <u>mit</u> Patientenkontakt <u>nicht</u> für Einsätze ohne Patientenkontakt (diese sollen unter KeinTranspOhnePat dokumentiert werden) 02 = primäre Todesfeststellung (ohne CPR); keine Todesfeststellungen ohne Reanimation (Erstbefunde sind erforderlich, Abschlussbefunde/Diagnosen/RD-Maßnahmen sind nicht erforderlich.) Der Grund für die nicht durchgeführte Reanimation muss in Feld Reanimationssituation angegeben werden! Sobald Reanimationsmaßnahmen durchgeführt wurden, darf im Feld KeinTranspMIPat <u>nicht</u> die 02 ausgewählt werden und in Feld Reanimationssituation muss 04 gewählt werden. Erfolgreiche Reanimationen werden mit dem Code 03 = Patient im Einsatzverlauf verstorben dokumentiert. Wenn Reanimationsmaßnahmen durch andere erfolgen und bei Eintreffen des eigenen RM der ROSC fortbesteht, darf im Feld KeinTranspMIPat <u>nicht</u> die 02 ausgewählt werden und in Feld Reanimationssituation muss 04 gewählt werden. Die Dokumentation über das Vorliegen eines Einsatzes ohne Transport trotz stattgehabtem Patientenkontakt erfolgt in Kombination mit dem Feld RDTransport (01 = kein Patienten-transport, trotz Patientenkontakt).	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Pflicht wenn: RDTransport GLEICH 01 Wenn RDTransport NICHT 01, sind sämtliche Inhalte in KeinTranspMIPat außer -2 unzulässig.	-2
KeinTranspOhnePat	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Grund für Einsatz ohne Transport, da kein Patientenkontakt Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Pflicht für Einsätze ohne Transport wegen fehlendem Patientenkontakt nur für Einsätze <u>ohne</u> Patientenkontakt; <u>nicht</u> für Einsätze mit Patientenkontakt ohne Patienten-transport (diese müssen unter KeinTranspMIPat dokumentiert werden) Die Dokumentation über das Vorliegen eines Einsatzes ohne Transport aufgrund fehlenden Patientenkontakts erfolgt in Kombination mit dem Feld RDTransport (02 = kein Patienten-transport, da kein Patientenkontakt).	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Pflicht wenn: RDTransport GLEICH 02 Wenn RDTransport NICHT 02, sind sämtliche Inhalte in KeinTranspOhnePat außer -2 unzulässig.	-2
DokRM	Ja	E	Rettungsmitteltyp des dokumentierenden Rettungsmittels Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Codierung des Rettungsmittels, welches den Einsatz abwickelt und dokumentiert.	Wenn Protokolltyp NA dann sind DokRM GLEICH (02 ODER 03 ODER 10 ODER 11 ODER 12 ODER 15 ODER 17 ODER 18 ODER 20) unzulässig	
BoleiRM	Nein	M	Rettungsmitteltypen des/der beteiligten Rettungsmittels Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Codierung der am Einsatz beteiligten Rettungsmittel Wird in der Regel durch die Leitstelle dokumentiert.	Wenn Protokolltyp RD dann sind DokRM GLEICH (01 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 13 ODER 14 ODER 16 ODER 19) unzulässig.	-2
AerztQualifikation	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	M	Fachrichtung/Qualifikation des Notarztes/Transportarztes Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Pflicht für NA-Protokolle, außer für Dienstfahrten oder Pauseneinsätze Es ist immer die Fachrichtung/Qualifikation des dokumentierenden Arztes einzutragen	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	-2
StatusPersonal	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Status des Personals Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Qualifikation des höchstqualifizierten Mitarbeiters auf dem Rettungsmittel. Beim notarztbesetzten Rettungsmittel die des Notarztes, beim nicht NA-besetzten Rettungsmittel die des Rettungsdienstmitarbeitenden. Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseneinsätze	Pflicht wenn: EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	-2
Kapitel: ZahlenEinsatzkategorie Einsatzdatum	Ja	E	Einsatzdatum	NA + RD	Einsatzdatum bezieht sich auf den Zeitpunkt der Alarmierung.	(dieses Kapitel ist immer Pflicht)	

Kapitel/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MINO
Symptombeginn/Vor24h	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Bestehen die Symptome länger als 24 Stunden oder ist dies unbekannt? Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Pflicht für NA-Protokolle bei Primäreinsätzen, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR) oder eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen RM handelt. Pflicht für RD-Protokolle bei Primäreinsätzen ohne erkennbare Beteiligung eines physisch anwesenden NA, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR) oder eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen RM handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND EinsatzArt GLEICH (01 ODER 03) UND KeinTranspMitPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND EinsatzArt GLEICH (03 ODER 04) UND NotarztWachegefordert GLEICH 02 UND KeinTranspMitPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08)	-2
Symptombeginn	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Ereigniszeitpunkt, Unfallzeitpunkt, Kollapszeitpunkt, Zeitpunkt Symptom/Beschwerdebeginn	NA + RD	Wenn der Symptombeginn bzw. Unfall-/Ereignis-/Kollapszeitpunkt (bekannt oder geschätzt) innerhalb von 24 Stunden vor Alarmierung liegt, ist die Uhrzeit hier anzugeben.	Pflicht wenn: SymptombeginnVor24h GLEICH 02 UND EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
Symptombeginn/Geschicht	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Ist der Symptombeginn geschicht oder geschätzt?	NA + RD	Gibt es belastbare Angaben zum Symptombeginn durch Patienten, Angehörige, Zeugen, etc.?	Pflicht wenn: SymptombeginnVor24h GLEICH 02 UND EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	-2
ZeitNotfallmeldung	Nein	E	Zeitpunkt Eingang Notfallmeldung in LST	NA + RD	Definition: Zeitpunkt des Anrufes (Anrufzeitpunkt aus Leitstellen-Datensatz) Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-03; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitAlarm	Nein	E	Zeitpunkt Alarm/Auftragsvergabe	NA + RD	Definition: Auslösung Alarm durch LST Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-02; 02/27-03; 00.000-0 1:00
ZeitAusweichen	Nein	E	Zeitpunkt Abfahrt/fähig Standort Status 3	NA + RD	Definition: Ausweichen des einzusetzenden Rettungsmittels (Bereitstellung komplett) Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitAnkunft/Einsatzort	Nein	E	Zeitpunkt Ankunft Einsatzort Status 4	NA + RD	Definition: Ankunft des dokumentierenden RM am Einsatzort. Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitAnkunft/Patientenkontakt	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Zeitpunkt Ankunft Patient	NA + RD	Definition: Ankunft der Rettungsmittelbesatzung beim Patienten bzw. Beginn der Übernahme des Patienten bei Sekundäreinsätzen. Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfeleistung oder die Unterstützung eines anderen RM handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um einen Krankentransport oder um eine Hilfeleistung oder die Unterstützung eines anderen RM handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND KeinTranspMitPat NICHT (05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND NICHT (EinsatzArt GLEICH 10, ODER KeinTranspMitPat GLEICH 05 ODER 08)	1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitTransportbeginn	Nein	E	Zeitpunkt Transportbeginn Status 7	NA + RD	Definition: Beginn des Patiententransportes. Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitEintreffen Transportziel	Nein	E	Zeitpunkt Eintreffen Transportziel Status 8	NA + RD	Definition: Fahrzeug trifft am Transportziel ein Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitJahrgang/Patient	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Übergabe des Patienten an Weiterbehandler	NA + RD	Definition: Übergabe an Personal der Zielklinik/Psaxis oder Übergabe an anderes Rettungsmittel (Übergang der Verantwortung für den Patienten). Bei Einsätzen ohne Patiententransport optional als Abschluss der Behandlung. Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattgefunden hat (Übergabezeitpunkt an Klinik bzw. an anderes transportierendes RM, wenn dokumentierende NA den Transport nicht begleitet). Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patiententransport durch das dokumentierende RM stattgefunden hat und keine notwendige Begleitung erfolgt bzw. die Begleitung ausschließlich durch einen NA durchgeführt wurde.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AerztBegleit ENTHALTEN (00 ODER 03) UND AerztBegleit ENTHALTEN NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 98)	1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitEinsatzende	Ja	E	Zeitpunkt Einsatzende	NA + RD	Definition: Einsatz ist abgeschlossen (inkl. aller mit dem Einsatz zusammenhängenden Arbeiten wie z.B. Desinfektionstillstände und Dokumentationen).		

Kapitel-/Eldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Kapitel: Patientendaten					Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich beim dokumentierten Rettungsmittel um einen Krankentransport, eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND KeinTranspMitPat NICHT (05 ODER 06) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND NICHT (EinsatzArt GLEICH 10 ODER KeinTranspMitPat GLEICH 05 ODER 98)	
Alter	Ja	E	Alter des Patienten Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Spezifische Dokumentation für Kinder unter einem Monat (siehe Codes) Angabe in vollendeten Jahren und Lebensmonaten (Bezugspunkt ist die Eintrittszeit). Ab dem 29. Lebenstag gilt der erste Lebensmonat als vollendet. In diesem Fall ist der Wert 000:01 zu übermitteln Wenn das Alter nicht bekannt ist, soll es geschätzt werden. Auch in seltenen Fällen, wenn die Schätzung des Alters schwierig ist, soll trotzdem eine grobe Vermutung dokumentiert werden	Wenn Kapitel "Patientendaten" Pflicht, dann ist 222:00 unzulässig	222:00
ValidesAlter	Ja	E	Ist das Alter gesichert oder geschätzt? Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "Patientendaten" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Geschlecht	Ja	E	Geschlecht des Patienten Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "Patientendaten" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Kapitel: ErsteMesswerteUndBefunde			Erste gemessene Werte bzw. erste erhobene Befunde		Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um einen Krankentransport, eine Hilfestellung, eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels oder um eine Verlegung mit physisch anwesendem Notarzt handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND KeinTranspMitPat NICHT (05 ODER 06) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND KeinTranspMitPat NICHT (05 ODER 06) UND EinsatzArt NICHT (05 ODER 07 ODER 10)	
Bewusstsein1	Ja	E	Bewusstseinslage Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Es ist die jeweils beste Ausprägung zu wählen	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
GlasgowComaScale1	Ja	E	Glasgow Coma Scale Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bei Seitendifferenz bessere Seite	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
NeurologischeAuffälligkeiten1	Ja	M	Neurologische Auffälligkeiten Werteliste siehe Tabellenblatt	NA + RD	+ aNHSS-EMS Items und BEFAST werden abgebildet. + die Dokumentation von Schweregraden und der Körperseite ist im MIND nicht vorgesehen	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit 00...1 oder 99 sind unzulässig.	-2
SystolischerBlutdruck1	Ja	E	Systolischer Blutdruck Messwert in mmHg Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet RR-Messung durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999.	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
EKGBefund1	Ja	M	EKG-Befund Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Hier sollen nur die Ausprägungen dokumentiert werden, die zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung zutreffend waren (nicht diejenigen in weiteren Verlauf). Für QS wird EKG als durchgeführt gewertet, wenn Angabe ungleich -1.	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit...1 oder 99 sind unzulässig.	-2
Herzfrequenz1	Ja	E	Herzfrequenz Messwert in /min Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Vom Monitor abgelesene Herzfrequenz pro Minute (ggf. palpatorisch oder pulsoximetrisch bestimmte Pulsfrequenz, wenn kein EKG abgebildet wurde).	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Werte GRÖßER 0 bei EKGBefund1 GLEICH 09 sind unzulässig.	-2
Atemfrequenz1	Ja	E	Atemfrequenz Messwert in /min Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Ausgehörte oder vom Monitor abgelesene Atemfrequenz pro Minute.	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Werte GRÖßER 0 bei Atmung1 GLEICH 08 sind unzulässig.	-2
Sauerstoffsättigung1	Ja	E	Sauerstoffsättigung Messwert in % Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet Pulsoxymetrie durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999. Der Erstbefund der Sauerstoffsättigung sollte möglichst vor Therapie mit Sauerstoff ermittelt werden.	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Rekapillarisierungszeit	Ja	E	Rekapillarisierungszeit Messwert in s Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Schmerzempfinden1	Ja	E	Schmerzempfinden nach Numerischer Rating Scale (NRS) Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Erstbefund des Schmerzempfindens vor dem Einleiten von Maßnahmen.	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Wenn Bewusstseint GLEICH 05, dann ist Schmerzempfinden GLEICH (01 bis 10) unzulässig.	-2
Schmerz erleben	Nein	E	Schmerz erleben Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Mit dem Schmerzerleben soll der subjektive Bedarf eines Patienten nach einer Schmerztherapie zum Ausdruck gebracht werden und damit deren Indikation dokumentiert werden.	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen.	-2
Blutzuckermesswert	Ja	E	Blutzucker Messwert in mg/dl bzw. mmol/l Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet Blutzuckermessung durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich, 997, 998 oder 999	Bei Auswahl 0 bis 900 bzw. 0.0 bis 50.0 wird BlutzuckerEinheit zum Pflichtfeld Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2

Kapitel-/Eldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal/ Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Pausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
BlutzuckerEinheit	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Ermöglicht die Dokumentation der im jeweiligen Bundesland / Rettungsdienstbereich gültigen Maßeinheit für den Blutzuckerwert	Pflicht wenn: Blutzuckerwert1 ODER Blutzuckerwert2 ENTHÄLT (0 bis 900 bzw. 0.0 bis 50.0)	-2
Temperatur		E	Temperatur Messwert in Grad Celsius Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet Temperatur-Messung durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 99.9. Keine explizite Ortsangabe, wenn möglich zentral (Tympanon)	Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Atmung?	Ja	M	Klinische Befunde Atmung Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Hier sollen nur die Ausprägungen dokumentiert werden, die zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung zutreffend waren (nicht diejenigen im weiteren Verlauf).	Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1, 00 oder 99 sind unzulässig.	-2
Haubbefunde	Ja	M	Haubbefunde Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1, 00 oder 99 sind unzulässig.	-2
Psychst	Ja	M	Psychischer Zustand Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Hier sollen nur die Ausprägungen dokumentiert werden, die zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung zutreffend waren (nicht diejenigen im weiteren Verlauf).	Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1, 00 oder 99 sind unzulässig.	-2
Pupillenweite1	Ja	E	Pupillenweite Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Es ist die klinisch relevanteste Ausprägung zu dokumentieren	Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Lichtreaktion1	Ja	E	Lichtreaktion Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
EICOWert1	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes eher gemessener eICo ₂ Wert (unter Beatmung in mmHg gemessen) Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet Kapnometrie durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999. Pflicht, wenn eine Atemwegsicherung oder eine maschinelle invasive Beatmung (unterstützt oder kontrolliert) dokumentiert ist	Pflicht wenn: Airway GLEICH (03 ODER 05 ODER 07) ODER Atemunterst GLEICH 05	-2
Kapitel: ErstbefundeVerlegung					Pflicht für NA-Protokolle, wenn eine Verlegung mit physisch anwesendem NA oder ein Intensivtransport stattfindet. (Für RD-Protokolle ist dieses Kapitel nie Pflicht.)	Die Abhängigkeiten des gesamten Kapitels betreffen nur das Bundesland Baden-Württemberg Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND Einsatzort GLEICH (05 ODER 07 ODER 08)	
VBeatmung	Ja	E	Beatmung (außer Hembbeatmung) Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA		Wenn Kapitel "ErstbefundeVerlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
VBeatmungDetail	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	differenzierte Beatmung Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Differenzierte Beatmung bedeutet FQ2 > 0,4. Pflicht, wenn im Kapitel "Erstbefunde Verlegung" eine Beatmung dokumentiert wurde.	Pflicht wenn: VBeatmung GLEICH 01 Wenn VBeatmung GLEICH 01, dann ist -2 unzulässig.	-2
KatecholaminPflicht	Ja	E	Katecholaminpflichtigkeit Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA		Wenn Kapitel "ErstbefundeVerlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
KatecholaminTherapie	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	differenzierte Katecholamin-Therapie Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Differenzierte Katecholamin-Therapie bedeutet mehr als ein Katecholamin. Pflicht, wenn im Kapitel "Erstbefunde Verlegung" eine Katecholaminpflichtigkeit dokumentiert wurde.	Pflicht wenn: KatecholaminPflicht GLEICH 01 Wenn KatecholaminPflicht GLEICH 01, dann ist -2 unzulässig.	-2
FortlaufendSedierung	Ja	E	fortlaufende Sedierung/Narkose Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA		Wenn Kapitel "ErstbefundeVerlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
VigilanzMinderung	Ja	E	deutliche Vigilanzminderung mit Einschränkung von Schutzreflexen Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Deutliche Vigilanzminderung mit Einschränkung von Schutzreflexen gilt bei GCS < 9.	Wenn Kapitel "ErstbefundeVerlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
InvasivBlutdruck	Ja	E	invasive Blutdruckmessung Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA		Wenn Kapitel "ErstbefundeVerlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
SpeziDevices	Ja	M	spezielle Devices Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Siehe Exporthinweise zu Option "Sonstige".	Wenn Kapitel "ErstbefundeVerlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
AnzahlPerfuser	Ja	E	Anzahl der Perfusoren Einstellbar numerische Angabe (0 bis 9)	NA		Wenn Kapitel "ErstbefundeVerlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Kapitel: EinschätzungVerlegungsarzt					Pflicht für NA-Protokolle, wenn bzw. Feld Einsatzort eine Verlegung mit physisch anwesendem NA oder ein Intensivtransport stattfindet. (Für RD-Protokolle ist dieses Kapitel nie Pflicht.)	Die Abhängigkeiten des gesamten Kapitels betreffen nur das Bundesland Baden-Württemberg Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND Einsatzort GLEICH (05 ODER 07 ODER 08)	
IndikationArztbegleitung	Ja	E	Indikation Arztbegleitung gegeben Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA		Wenn Kapitel "EinschätzungVerlegungsarzt" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
ZDringlichkeit	Ja	E	Einschätzung der zeitlichen Dringlichkeit durch Transportarzt Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA		Wenn Kapitel "EinschätzungVerlegungsarzt" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Indikation?	Ja	M	Indikation Intensivtransport Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Siehe Exporthinweise zu Option "Sonstige". Die Antwort NEIN ist implausibel, wenn im Kapitel "ErstbefundeVerlegung" sowohl eine Beatmung als auch eine Katecholaminpflichtigkeit dokumentiert sind.	Wenn VBeatmung GLEICH 01 UND KatecholaminPflicht GLEICH 01, dann ist Code 00 unzulässig. Wenn Kapitel "EinschätzungVerlegungsarzt" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit 00 sind unzulässig.	-2

Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Kapitel: Diagnosen					Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um einen Krankentransport, eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt oder ein physisch anwesender NA primär mitalarmiert oder nachgefordert wurde. Hinweis für BW: Wenn eine Diagnose, für die ein Indikator zur Eignung der Zielklinik oder zur leitliniengerechten Versorgung dieser Diagnose existiert, im Diagnosen-Feld dokumentiert ist, wird auch eine entsprechend geeignete Zielklinik und leitliniengerechte Versorgung erwartet. Eher unwahrscheinliche Differentialdiagnosen sollen im Einleitfeld dokumentiert werden.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) UND NotarztNachgefordert GLEICH 02 UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 04 ODER 06 ODER 08)	
Diagnose	Ja	M	Verdachtsdiagnose(n) Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Hier sollen nur einsatzrelevante Diagnosen und keine Vorerkrankungen dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notärztin/des Notarztes bzw. der Notfallsanitäterin/des Notfallsanitäters + Verstorbene Patienten können mit 1220 + Herz-Kreislauf-Stillstand oder 1813 + SIDS codiert werden. + Bei einer Anaphylaxe Grad 4 soll zusätzlich die Diagnose 1220 + Herz-Kreislauf-Stillstand dokumentiert werden. + Bei indirekten Verletzungen soll zusätzlich die Diagnose 1220 + Herz-Kreislauf-Stillstand dokumentiert werden. + Bitte die Differenzierung zwischen hypertensivem Notfall (mit Organschäden und Lebensgefahr, z.B. AP-, Beschwerden, Lungenödem, neurologische Symptome) und hypertensiver Engbrüstigkeit (ohne Organschäden/Lebensgefahr) beachten!	Wenn Kapitel "Diagnosen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
Kapitel: VerletzungenDetails					Pflicht für NA- und RD-Protokolle, wenn mindestens eine Verletzung aus Diagnosecodes mit führender 2 vorhanden.	Pflicht wenn: Mindestens ein Diagnose-Code GLEICH 2mm	
Verletzungsmuster	Ja	E	Verletzungsmuster Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Polytrauma: Gleichzeitig entstandene Verletzungen mehrerer Körperregionen oder Organsysteme, wobei wenigstens eine Verletzung oder die Kombination mehrerer lebensbedrohlich ist.	Wenn Kapitel "VerletzungenDetails" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
Unfallsache	Ja	E	Unfallsache Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "VerletzungenDetails" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
Unfallmechanismus	Ja	M	Unfallmechanismus Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "VerletzungenDetails" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
Unfallhergang	Ja	M	Unfallhergang Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Kombinationen mit 99 sind unzulässig Wenn Kapitel "VerletzungenDetails" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
HelmPat	Nein	E	Helm Patient Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Hat der/die Verunfallte zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm getragen?	Kombinationen mit 99 sind unzulässig	-2
Kapitel: Scores					Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um einen Krankentransport, eine Hilfestellung, eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels oder um eine Verlegung mit physisch anwesendem Notarzt handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (05 ODER 08) UND EinsatzArt NICHT (03 ODER 07 ODER 08)	
NACAScore	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Subjektive Einschätzung der Schwere der Erkrankung oder Verletzung durch das rettungsdienstliche Personal. Es gilt die jeweils schlimmste Ausprägung im Einsatzverlauf.	Wenn Kapitel "Scores" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
MNACAScore	Nein	E	M-NACAScore Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Objektivierung des NACA-Scores. Soll aus dokumentierten Feldern berechnet werden!		-2

Kapitel-/Eldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Kapitel: RDMassnahmen					Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um einen Krankentransport, eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt oder ein physisch anwesender NA primär mitalarmiert oder nachgefordert wurde.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMMPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMMPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) UND NaturHochgefahrortent GLEICH 02 UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 04 ODER 06 ODER 08)	
Airway	Ja	M	Airway Maßnahmen Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bei vorbestehendem Tracheostoma ohne eigene Maßnahmen soll "keine Maßnahmen durchgeführt" codiert werden	Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
Alernunterst	Ja	M	Alernunterstützung - Bestimmung Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
CirculationZugang	Ja	M	Medikamentenzugang Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
SpecMassen	Ja	M	Spezielle Maßnahmen Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
EKG12Kanal	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	M	Dokumentation eines 12-Kanal-EKGs Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Pflicht bei dokumentiertem ACS, STEMI oder Thoraxschmerz unklarer Genese	Pflicht wenn: Diagnose ENTHÄLT (1201 ODER 1202 ODER 1203 ODER 1204) Wenn EKG12Kanal Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Medizintechnik	Ja	M	Medizintechnik Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Kombinationen mit -1 sind unzulässig. Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
LagTrans	Ja	M	Lagerungs- und Rettungstechnik Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Mit HWS-Immobilisation ist nicht nur die Anlage einer Cervicstütze gemeint, sondern auch andere Methoden der Immobilisation wie z.B. Headlocks	Kombinationen mit -1 sind unzulässig. Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
DurchfHeilkundMacon	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	M	Durchführung heilkundlicher Maßnahmen Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	RD	Hiermit sind durchgeführte heilkundliche Maßnahmen durch Notfallanwiter gemeint	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH RD UND DokRM GLEICH (02 ODER 15) Wenn DurchfHeilkundMassen Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Behandlungsgrad	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	M	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	RD	Hier soll dokumentiert werden, welcher Behandlungsgrad genutzt wurde (jeweils Standardarbeitsanweisungen, Algorithmen, Handlungsempfehlungen etc. nach örtlicher Vorgabe)	Kombinationen mit 03 sind unzulässig. Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH RD UND DurchfHeilkundMassen GLEICH (01 ODER 02) Wenn Behandlungsgrad Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Kapitel: MedikamentöseTherapie					Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um einen Krankentransport, eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt oder ein physisch anwesender NA primär mitalarmiert oder nachgefordert wurde.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMMPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMMPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) UND NaturHochgefahrortent GLEICH 02 UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 04 ODER 06 ODER 08)	
Medikamentengabe	Ja	M	Medikamentencodes für Art des Medikaments und Applikationsweg Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Nur einsatzrelevante Medikamente dokumentieren. Auch eine Vorbehandlung durch Andere soll dokumentiert werden, da diese für verschiedene Indikatoren relevant sein kann (für jede Medikamenten-Gruppe separat dokumentierbar).	Wenn Kapitel "MedikamentöseTherapie" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit 99999 sind unzulässig.	-2
Infusionsgabe	Ja	M	Medikamentencodes für Art der Infusion und Applikationsweg Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Dauermedikation und Verabreichung durch Andere (Hausarzt, andere Rettungsmittel etc.): re97xx Nur einsatzrelevante Medikamente dokumentieren Dauermedikation und Verabreichung durch Andere (Hausarzt, andere Rettungsmittel etc.): re97xx	Wenn Kapitel "MedikamentöseTherapie" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit 99999 sind unzulässig.	-2

Kapitel-/Eldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Kapitel: AbschlussBefundeBT			Abschlussbefunde bei Transport		Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattgefunden hat. Sofern der dokumentierende NA den Transport nicht begleitet, müssen die Befunde zum Zeitpunkt der Übergabe an das andere Rettungsmittel dokumentiert werden (z.B. für Feld On-Fallübergang u.d.R. 15 = Einsatzstelle). Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattfand und der Transport nicht durch einen physisch anwesenden Notarzt, sondern allenfalls durch einen Telenotarzt begleitet wird und es sich nicht um einen Krankentransport handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AездBegleit ENTHÄLT 00 ODER 01 UND AездBegleit ENTHÄLT NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 98) UND EinsatzArt NICHT 10	
Bewusstsein2	Ja	E	Bewusstseinslage Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
GlasgowComaScale2	Ja	E	Glasgow Coma Scale Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bei Seitendifferenz bessere Seite.	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
NeurologischeAuffälligkeiten2	Ja	M	Neurologische Auffälligkeiten Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	+ eNWS-EMS Items und BEFAST werden abgebildet. + die Dokumentation von Schweregraden und der Körperseite ist im MIND nicht vorgesehen	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit 00, -1 oder 99 sind unzulässig.	-2
SystemischerBlutdruck2	Ja	E	Systemischer Blutdruck Messwert in mmHg Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet RR-Messung durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999.	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
EKGbefund2	Ja	M	EKG-Befund Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Sollten bei Erhebung der Abschlussbefunde mehrere Befunde zutreffen, ist eine Mehrfachauswahl möglich (hier jeden keine Ausprägungen dokumentiert werden, die vorher im Verlauf des rettungsdienstlichen Einsatzes zutreffend waren und nicht mehr vorhanden sind). Für QS wird EKG als durchgeführt gewertet, wenn Angabe ungleich -1.	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig Kombinationen mit -1 oder 99 sind unzulässig.	-2
Herzfrequenz2	Ja	E	Herzfrequenz Messwert in /min Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Vom Monitor abgelesene Herzfrequenz pro Minute (ggf. palpatrisch oder pulsoximetrisch bestimmte Pulsfrequenz, wenn kein EKG abgeleitet wurde).	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Wenn EKGbefund2 GLEICH 09, dann sind Werte GRÖßER 0 unzulässig.	-2
Atemfrequenz2	Ja	E	Atemfrequenz Messwert in /min Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Ausgehäutete oder vom Monitor abgelesene Atemfrequenz pro Minute.	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Wenn Atmung2 GLEICH 08, dann sind Werte GRÖßER 0 unzulässig.	-2
Sauerstoffsättigung2	Ja	E	Sauerstoffsättigung Messwert in % Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Dieser Wert wird ggf. unter Sauerstofftherapie gemessen Bedeutet Pulsoxymetrie durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999.	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Schmerzempfinden2	Ja	E	Schmerzempfinden nach Numerischer Rating Scale (NRS) Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Atmung2	Ja	M	Klinische Befunde Atmung Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Sollten bei Erhebung der Abschlussbefunde mehrere Befunde zutreffen, ist eine Mehrfachauswahl möglich (hier jeden keine Ausprägungen dokumentiert werden, die vorher im Verlauf des rettungsdienstlichen Einsatzes zutreffend waren und nicht mehr vorhanden sind).	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1, 00 oder 99 sind unzulässig.	-2
Psyche2	Ja	M	Psychischer Zustand Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Sollten bei Erhebung der Abschlussbefunde mehrere Befunde zutreffen, ist eine Mehrfachauswahl möglich (hier jeden keine Ausprägungen dokumentiert werden, die vorher im Verlauf des rettungsdienstlichen Einsatzes zutreffend waren und nicht mehr vorhanden sind).	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1, 00 oder 99 sind unzulässig.	-2
Pupillenweite2	Ja	E	Pupillenweite Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Lichtreaktion2	Ja	E	Lichtreaktion Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2

Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Pausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
SoStTransport	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Sondersignal bei Transport: Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Sondersignaleverwendung des transportierenden Rettungsmittels. Bei Patienten-Transport durch Hubschrauber: 01 = Ja Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patienten-Transport stattgefunden hat, der durch den dokumentierenden NA begleitet wurde. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patienten-Transport stattfindet und der Transport nicht durch einen physisch anwesenden Notarzt, sondern ebenfalls durch einen Telenotarzt begleitet wird und es sich nicht um einen Krankentransport handelt...	Wenn Kapitel "AbschlussbefunddBTV" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (01 ODER 04 ODER 07 ODER 13) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit GLEICH 01 ODER Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (05 ODER 06) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit GLEICH 02 ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit ENTHÄLT (00 ODER 03) UND AertzBegleit ENTHÄLT NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 98) UND EinsatzArt NICHT 10	-2
OPPaUeberg	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Der Ort, an dem der Patient primär übergeben wird. Sollen mehrere Auswahlmöglichkeiten zutreffen, ist die für die Weiterversorgung des jeweiligen Patienten spezifischste anzugeben. Sofern der dokumentierende NA den Transport nicht begleitet, ist i.d.R. 15 = Einsatzstelle zutreffend.	Wenn Kapitel "AbschlussbefunddBTV" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Kapitel: AbschlussBefunddBTV			Abschlussbefunde bei Transport und ambulanter Versorgung		Pflicht für NA- und RD-Protokolle, wenn die Diagnose Hyponyktämie gestellt wurde oder wenn eine Atemwegsicherung oder eine maschinelle invasive Beatmung (unterstützt oder kontrolliert) stattgefunden hat	Pflicht wenn: Airway GLEICH (03 ODER 05 ODER 07) ODER Atemunterst GLEICH 05 ODER Diagnose ENTHÄLT 1001 (Hyponyktämie) Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Pausibilitätsprüfungen.	
Blutzuckerwert2	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Blutzucker Messwert in mg/dl bzw. mmol/l Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet Blutzuckermessung durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich: 557, 568 oder 599	Bei Auswahl 0 bis 500 bzw. 0,0 bis 50,0 wird BlutzuckerEinheit zum Pflichtfeld Pflicht wenn: Diagnose ENTHÄLT 1001 Wenn Blutzuckerwert2 Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
EiCO2Wert2	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	eCO ₂ Wert (zuletzt unter Beatmung in mmHg gemessen) Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet Kapnometrie durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999. Pflicht wenn Atemwegsicherung oder maschinelle invasive Beatmung (unterstützt oder kontrolliert) dokumentiert	Pflicht wenn: Airway GLEICH (03 ODER 05 ODER 07) ODER Atemunterst GLEICH 05 Wenn EiCO2Wert2 Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Kapitel: Zielklinik					Pflicht für NA-Protokolle, wenn es sich bei dem dokumentierenden Rettungsmittel um ein luftgebundenes notarztbesetztes Rettungsmittel handelt, ein Patienten-Transport stattfindet und der Notarzt den Transport begleitet oder der RTW den Transport ohne ärztliche Begleitung durchführt. Pflicht für NA-Protokolle, wenn es sich bei dem dokumentierenden Rettungsmittel um ein luftgebundenes notarztbesetztes Rettungsmittel handelt, ein Patienten-Transport stattfindet und der Notarzt den Transport begleitet oder der RTW den Transport ohne ärztliche Begleitung durchführt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patienten-Transport stattfindet und der Transport nicht durch einen physisch anwesenden Notarzt, sondern ebenfalls durch einen Telenotarzt begleitet wird	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (01 ODER 04 ODER 07 ODER 13) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit ENTHÄLT (00 ODER 01) ODER Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (05 ODER 06) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit ENTHÄLT (00 ODER 02) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit ENTHÄLT (00 ODER 03) UND AertzBegleit ENTHÄLT NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 98)	

Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
NummerZK	Ja	E	Kennung der Zielklinik Wertefeld siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Standortnummer nach §293 Absatz 6 SGB V aus dem bundesweiten Verzeichnis der Standorte der nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen. Falls nur die Standort-ID bekannt ist (= erste 6 Stellen der Standortnummer) ist diese nach der 6. Stelle mit "0" (Null) auf 9 Stellen aufzufüllen: Standortnummer (9-stellig: 77nnnnnn) oder Standort-ID (6-stellig: 77nnnn000) der Zielklinik. Einmalige Anlage aller regelhaft angefahren/angeflogenen Krankenhäuser der Akutversorgung in Stammdatenbank erforderlich. Für Einrichtungen ohne Standortnummer müssen auf örtlicher Ebene alternative Definitionen getroffen werden.	Wenn Kapitel "Zielklinik" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
AnmeldungPatient	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Wurde der Patient in der Zielklinik angemeldet? Muss bei Patiententransport angegeben werden, auch wenn die Anmeldung durch die Leitstelle erfolgt. Wertefeld siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Patientenanmeldung durch Fahrzeugbesatzung oder Leitstellenpersonal. Mindestens einmal pro Patient erforderlich. Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattgefunden hat, der durch den dokumentierenden NA begleitet wurde. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattfindet und der Transport nicht durch einen physisch anwesenden Notarzt, sondern allenfalls durch einen Telenotarzt begleitet wird und es sich nicht um einen Krankentransport handelt.	Wenn Kapitel "Zielklinik" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (01 ODER 04 ODER 07 ODER 13) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBoglet GLEICH 01 ODER Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (05 ODER 06) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBoglet GLEICH 02 ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBoglet ENTHÄLT (00 ODER 03) UND AertzBoglet ENTHÄLT NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 96) UND EinsatzArt NICHT 10	-2
Kapitel: EinsatzBesonderheiten						Pflicht wenn: EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	
EinsatzBesonderheiten	Ja	M	Einsatzbesonderheiten Wertefeld siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	+ Abweichung von medizinischen Standards, + Abweichung vom Zielablauf, + erhöhter Aufwand. Ablehnung induzierter Maßnahmen (z.B. Diagnostik, Therapie) durch Patienten: 02. Transportverweigerung ist im Feld KeinTranspMitPat zu dokumentieren (04 = Patient lehnt Transport ab). Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseneinsätze	Kombinationen mit 03 sind unzulässig.	-2
PreEmergencyStatus	Nein	E	Wertefeld siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Schwere der Vorerkrankungen, Zustand vor Eintritt des Notfalls. Pflicht für NA-Protokolle, wenn die Diagnose Herz-Kreislauf-Stillstand, ein SIDS, eine primäre Todeserkrankung (ohne CPR) oder "Patient im Einsatzverlauf verstorben" dokumentiert wurde. Pflicht für RD-Protokolle, wenn die Diagnose Herz-Kreislauf-Stillstand dokumentiert wurde, oder bei einer Todesfeststellung bzw. einer Dokumentation des Todes im Einsatzverlauf, aber nur wenn eine Notfallmeldung ohne erkennbare primäre NA-Einschaltung vorliegt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND (Diagnose ENTHÄLT (1230 ODER 1813) ODER KeinTranspMitPat GLEICH (02 ODER 03)) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND (Diagnose ENTHÄLT (1230 ODER 1813) ODER KeinTranspMitPat GLEICH (02 ODER 03)) UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 04 ODER 06 ODER 98)	-2
Kapitel: Reanimation							
Reanimationsituation	Ja	E	Wurde eine Reanimation durchgeführt? Wertefeld siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Eine begonnene Reanimation ist mit 01 oder 02 oder 03 zu dokumentieren. Bei primärer Todesfeststellung (ohne CPR) ist nur "Reanimation nicht durchgeführt..." zulässig. Ohne Patientenkontakt ist nur "keine Reanimationsituation (kein Tod/kein Kreislaufstillstand)" zulässig. Bei Diagnose Herz-Kreislauf-Stillstand oder SIDS bzw. bei Dokumentation "Patient im Einsatzverlauf verstorben" ist "keine Reanimationsituation (kein Tod/kein Kreislaufstillstand)" unzulässig.	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Wenn KeinTranspMitPat GLEICH 02, dann ist Reanimationsituation GLEICH (00 ODER 01 ODER 02 ODER 03 ODER 94) unzulässig. Wenn RDtransport GLEICH 02, dann ist nur Reanimationsituation GLEICH 00 zulässig. Wenn Diagnose ENTHÄLT (1220 ODER 1813) ODER KeinTranspMitPat GLEICH 03 dann ist Reanimationsituation GLEICH 00 unzulässig.	-2
Kapitel: ReanimationDetails					Pflicht für NA-Protokolle, wenn dokumentierendes Rettungsmittel Reanimation durchgeführt hat. Pflicht für RD-Protokolle, wenn dokumentierendes Rettungsmittel Reanimation durchgeführt hat und eine Notfallmeldung ohne erkennbare NA-Beteiligung bzw. Nachforderung vorliegt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimationsituation GLEICH (01 ODER 02 ODER 03) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimationsituation GLEICH (01 ODER 02 ODER 03) UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 04 ODER 06 ODER 98) UND NotarztNachgefordert GLEICH 02	

Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Reanimations technik	Ja	M	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Reanimations situation GLEICH (00 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind alle Werte außer -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
URKRSTST	Ja	E	Vermutete Ursache des Kreislaufstillstandes Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Die internationalen Vorgaben des Utstein-Style Protokolls unterscheiden die Ursachen eines Kreislaufstillstandes in mehreren Sektionen. Gefragt ist die aus Sicht des Notarztes vermutliche Ursache.	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
SPORT	Nein	E	Zusammenhang mit sportlicher Aktivität: Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeht ein Zusammenhang des Kreislaufstillstandes mit sportlicher Aktivität?	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
ZEQFR	Nein	E	Zeitstempel Eintreffen First Responder Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Eintreffzeit eines First Responders als "Vorausversorger" neben dem regulären Rettungsdienst am Einsatzort.	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-02-02T22:00:00.000+01:00
ZCKB	Ja	E	Person Kollaps beobachtet Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Wer hat den Kollaps beobachtet? Erstshelfer entspricht dem nichtmedizinischen Personal bzw. Laien.	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
ZCHDM	Ja	E	Person Herzdruckmassage begonnen Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Wer hat mit der Herzdruckmassage begonnen bzw. den Beginn angeordnet? (Es ist die jeweils am höchsten qualifizierte anwesende Person zu dokumentieren.)	Wenn Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimations situation GLEICH (05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann ist 06 unzulässig. Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimations situation GLEICH (05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind 05 ODER 06 unzulässig. Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
ZCDEFI	Ja	E	Person Defibrillation durchgeführt Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Wer hat die erste Defibrillation durchgeführt bzw. angeordnet? (Es ist die jeweils am höchsten qualifizierte anwesende Person zu kodieren.)	Wenn Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimations situation GLEICH (05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann ist 06 unzulässig. Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimations situation GLEICH (05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind 05 ODER 06 unzulässig. Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
ZHDM	Ja	E	Zeitpunkt Beginn Herzdruckmassage Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Erster Zeitpunkt, zu dem mit der Herzdruckmassage begonnen wurde, ggf. schätzen.	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-02-02T22:00:00.000+01:00
ZDEFI1	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Zeitpunkt erste Defibrillation Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Zeitpunkt der ersten Defibrillation. Pflicht für NA-Protokolle, wenn eine Defibrillation durch den KTW, RTW oder NA dokumentiert wurde Pflicht für RD-Protokolle, wenn eine Defibrillation durch den KTW oder RTW dokumentiert wurde und eine Notfallleitung eine erkennbare NA-Beteiligung bzw. -Nachforderung vorliegt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND ZCDEFI GLEICH (04 ODER 05 ODER 06) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND ZCDEFI GLEICH (04 ODER 05) UND Einsatzart GLEICH 02 ODER 04 ODER 06 ODER 08 UND NotarztNachgefordert GLEICH 02 Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-02-02T22:00:00.000+01:00
ZROSC1	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Zeitpunkt 1. ROSC Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Bei Wiedereintritt eines Eigenkreislaufs (ROSC) ist die Zeit zu notieren. Ab diesem Zeitpunkt hat der Patient einen eigenen Kreislauf mit einem messbaren Puls. Auch wenn dieser wieder zusammenbricht, ROSC = return of spontaneous circulation (Spontankreislauf)	Pflicht wenn: ROSC GLEICH 02 Wenn Reanimations situation GLEICH (00 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind alle Werte außer "1902-02-02T00:00:00" unzulässig.	1902-02-02T22:00:00.000+01:00
ROSC	Ja	E	Erreichen eines Spontankreislaufs Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Könnte durch die Reanimationsmaßnahmen jemals ein spontaner Kreislauf > 20 Sekunden etabliert werden? Wenn bei Feld KHAUF "Krankenhausaufnahme mit ROSC", dann in Feld ROSC nur "jemals ROSC" zulässig.	Wenn KHAUF GLEICH 02, dann nur ROSC GLEICH 02 zulässig. Wenn Reanimations situation GLEICH (00 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
KHAUF	Ja	E	Patientenzustand bei Krankenhausaufnahme Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Zustand bei Übergabe an die Zielklinik.	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig. Wenn Reanimations situation GLEICH (05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind alle Werte außer 01 unzulässig.	-2
ZTOD	Nein	E	Zeitpunkt TOD Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Beendigungszeitpunkt der Reanimationsmaßnahmen.	Wenn Reanimations situation GLEICH (00 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind alle Werte außer "1902-02-02T00:00:00" unzulässig.	1902-02-02T22:00:00.000+01:00
ende							

3. Codes MIND

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Feldname	Werteliste	
Protokolltyp	NA RD	
Standortkennung	Amtlicher Gemeindeschlüssel des RM-Standortes -1 = nicht dokumentiert 99999999 = nicht bekannt	
EinsatzArt	Einsatzart 01 = Notfallrettung - Primäreinsatz nur mit (physisch anwesendem) NA 02 = Notfallrettung - Primäreinsatz nur mit TNA 03 = Notfallrettung - Primäreinsatz mit (physisch anwesendem) NA und TNA 04 = Notfallrettung - Primäreinsatz ohne NA 05 = Notfallrettung - Verlegung nur mit (physisch anwesendem) NA 06 = Notfallrettung - Verlegung nur mit TNA 07 = Notfallrettung - Verlegung mit (physisch anwesendem) NA und TNA 08 = Notfallrettung - Verlegung ohne NA 09 = Intensivtransport 10 = Krankentransport 11 = Dienstfahrt 12 = Pause	
Gemeindeschlüssel	Amtlicher Gemeindeschlüssel des Einsatzortes -1 = nicht dokumentiert 99999998 = Einsatzort im Ausland 99999999 = nicht bekannt	
Postleitzahl	Postleitzahl des Einsatzortes -1 = nicht dokumentiert 99999 = nicht bekannt	
EinsatzortTyp	Beschreibung des Einsatzortes -1 = nicht dokumentiert 01 = Wohnung 02 = Pflegeeinrichtung 03 = Arbeitsplatz 04 = Arztpraxis 05 = Straße 06 = öffentlicher Raum 07 = Krankenhaus 08 = Massenveranstaltung 09 = Bildungseinrichtung 10 = Sportstätte 11 = Geburtshaus/-einrichtung 12 = unwegsames Gelände 98 = Sonstige	
RDTransport	Rettungsdienstlicher Transport 01 = kein Patiententransport, trotz Patientenkontakt 02 = kein Patiententransport, da kein Patientenkontakt 03 = Transport durch RTW 04 = Transport durch NAW 05 = Transport durch RTH / ITH 06 = Transport durch KTW 07 = Transport durch N-KTW 08 = Transport durch S-RTW 09 = Transport durch ITW 98 = Transport durch sonstige Rettungsmittel	
AerztlBegleit	Ärztliche Transportbegleitung 00 = keine 01 = Begleitung durch NA bodengebunden 02 = Begleitung durch NA RTH 03 = Begleitung durch Telenotarzt 04 = Begleitung durch Krankenhaus-Arzt 05 = Begleitung durch niedergelassenen Arzt 98 = Begleitung durch sonstigen Arzt	
NotarztNachgefordert	Physisch anwesender Notarzt wurde nachgefordert 01 = Ja 02 = Nein	
TNANachgefordert	Tele-Notarzt wurde nachgefordert 01 = Ja 02 = Nein	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
KeinTranspMitPat	Grund für Einsatz ohne Transport trotz Patientenkontakt 01 = ambulante Versorgung, keine Klinikbehandlung notwendig 02 = primäre Todesfeststellung (ohne CPR durch das dokumentierende RM) 03 = Patient im Einsatzverlauf verstorben 04 = Patient lehnt Transport ab 05 = Hilfeleistung 06 = an ambulanten Sektor verwiesen (ÄBD, Hausarzt etc.) 07 = Patientenübergabe an Polizei 08 = Unterstützung eines anderen Rettungsmittels 09 = First Responder 10 = Einsatzabbruch aus Wettergründen 11 = Ausfall Rettungsmittel (Eigenunfall, technischer Defekt, Personal erkrankt) 12 = Rettungsmittel für Transport nicht geeignet 13 = Transport durch Dritte (z.B. Angehörige, Taxi) 98 = sonstige	
KeinTranspOhnePat	Grund für Einsatz ohne Transport, da kein Patientenkontakt 01 = Von Leitstelle abbestellt / Abbruch vor Erreichen des Notfallorts 02 = Kein Patient vorgefunden oder Patient bereits abtransportiert 03 = (Vorsorgliche) Bereitstellung 04 = Gebietsabdeckung 05 = Personaltransport (Notarztzubringer/LNA, OrgL,...) 06 = Materialtransport (Blut, spez. Devices,...) 07 = Einsatzabbruch aus Wettergründen 08 = Ausfall Rettungsmittel (Eigenunfall, technischer Defekt, Personal erkrankt) 98 = sonstige	
DokRM	Typ des dokumentierenden Rettungsmittels 01 = NEF 02 = RTW 03 = KTW 04 = NAW 05 = RTH 06 = ITH 07 = ITW 08 = Langstreckenflugzeug 09 = Ambulanzflugzeug 10 = First Responder 11 = Bergrettung 12 = Wasserrettung 13 = Selbstfahrender NA 14 = Telenotarzt 15 = Single Responder (Gemeinde-NotSan, REF, AEF,...) 16 = LNA 17 = OrgL 18 = N-KTW 19 = MIC 20 = S-RTW (Schwerlast) 98 = Sonstige	
BeteilRM	Typen der am Einsatz beteiligten Rettungsmittel 01 = NEF 02 = RTW 03 = KTW 04 = NAW 05 = RTH 06 = ITH 07 = ITW 08 = Langstreckenflugzeug 09 = Ambulanzflugzeug 10 = First Responder 11 = Bergrettung 12 = Wasserrettung 13 = Selbstfahrender NA 14 = Telenotarzt 15 = Single Responder (Gemeinde-NotSan, REF, AEF,...) 16 = LNA 17 = OrgL 18 = N-KTW 19 = MIC 20 = S-RTW (Schwerlast) 21 = Ersthelfer-App 98 = Sonstige	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
AerztQualifikation	Notärztl./Transportärztl.Fachgebiet/Qualifikation -1 = nicht dokumentiert 01 = Innere 02 = Chirurgie 03 = Anästhesie 04 = Pädiatrie 05 = Allgemeinmedizin 06 = Neurologie 07 = Zusatzbezeichnung Notfallmedizin 08 = Zusatzbezeichnung Intensivmedizin 09 = Zusatzbezeichnung Klinische Akut- und Notfallmedizin 10 = Ärztin/Arzt in Weiterbildung 11 = Fachärztin/-arzt 98 = Andere Fachrichtung	
StatusPersonal	Status des Personals -1 = nicht dokumentiert 01 = Ärztin/Arzt 02 = Notfallsanitäter/in 03 = Rettungsassistent/in 04 = Rettungssanitäter/in 05 = Intensivpflegepersonal 98 = Sonstige	
SymptombeginnVor24h	Bestehen die Symptome länger als 24 Stunden? 00 = unbekannt 01 = Ja 02 = Nein	
SymptombeginnGesichert	Ist der Symptombeginn gesichert oder geschätzt? 01 = Symptombeginn gesichert 02 = Symptombeginn geschätzt	
Alter	Patientenalter Wertebereich = 000:01 bis 125:00 (Jahre:Monate) 999:00 = Neugeboren: Geburt bis 28. Tag	
ValiditaetAlter	Ist das Alter gesichert oder geschätzt? 01 = gesichert 02 = geschätzt	
Geschlecht	Geschlecht des Patienten -1= nicht dokumentiert 01 = männlich 02 = weiblich 03 = divers	
Bewusstsein1 Bewusstsein2	Bewusstseinslage -1 = nicht untersucht 01 = analgosediert/Narkose 02 = wach 03 = reagiert auf Ansprache 04 = reagiert auf Schmerzreiz 05 = bewusstlos 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
GlasgowComaScale1 GlasgowComaScale2	Glasgow Coma Scale Wertebereich = 3 bis 15 -1 = nicht untersucht 99 = nicht beurteilbar	
NeurologischeAuffaelligkeiten1	Akute neurologische Auffälligkeiten (ZNS, PNS) -1 = nicht untersucht 00 = keine 01 = Gesichtslähmung (kein Lächeln/hängender Mundwinkel) F 02 = Motorik Arme (einseitiges Absinken <10s/kein Anheben/keine Bewegung) A 03 = Motorik Beine (einseitiges Absinken <5s/kein Anheben/keine Bewegung) 04 = Sehstörung/Doppelbilder 05 = Sprachstörung (Aphasie)/Sprechstörung (Dysarthrie) S 06 = Schluckstörung 07 = Sensibilitätsstörung 08 = Gangunsicherheit/Schwindel 09 = Herdblick 10 = Übelkeit/Erbrechen 11 = Kopfschmerzen 12 = Meningismus 13 = Babinski Zeichen 14 = Querschnittssymptomatik 97 = vorbestehendes neurolog. Defizit 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
SystolischerBlutdruck1 SystolischerBlutdruck2	Systolischer Blutdruck - Messwert in mmHg <i>Wertebereich = 0 bis 300</i> -1 = nicht gemessen 999 = nicht messbar	
EKGBefund1 EKGBefund2	EKG-Befund -1 = kein EKG durchgeführt 01 = Sinusrhythmus 02 = absolute Arrhythmie 03 = AV-Block II 04 = AV-Block III 05 = schmale QRS-Tachykardie 06 = breite QRS-Tachykardie 07 = Kammerflimmern 08 = pulslose elektrische Aktivität 09 = Asystolie 10 = Schrittmacherrhythmus 11 = signifikante ST-Hebungen 12 = Schenkelblock 98 = Sonstige 99 = nicht durchführbar/nicht beurteilbar	
Herzfrequenz1 Herzfrequenz2	Herzfrequenz - Messwert in /min <i>Wertebereich = 0 bis 300</i> -1 = nicht gemessen 999 = nicht beurteilbar	
Atemfrequenz1 Atemfrequenz2	Atemfrequenz <i>Wertebereich = 0 bis 98</i> -1 = nicht gemessen 99 = nicht beurteilbar	
Sauerstoffsättigung1 Sauerstoffsättigung2	Sauerstoffsättigung - Messwert in % <i>Wertebereich = 0 bis 100</i> -1 = nicht gemessen 999 = nicht messbar	
Rekapillarierungszeit	Rekapillarierungszeit - Messwert in s <i>Wertebereich = 1 bis 10</i> -1 = nicht gemessen 11 = größer 10 Sekunden	
Schmerzempfinden1 Schmerzempfinden2	Schmerzempfinden - nach Numerischer Rating Scala (NRS) <i>Wertebereich = 0 bis 10</i> -1 = nicht gemessen 99 = nicht beurteilbar	
Schmerzerleben	Schmerzerleben durch Patienten 00 = tolerabel 01 = nicht tolerabel	
Blutzuckerwert1 Blutzuckerwert2	Blutzucker Messwert in mg/dl bzw. mmol/l <i>Wertebereich = 0 bis 900 bei Einheit mg/dl bzw.</i> <i>Wertebereich = 0.0 bis 50.0 bei Einheit mmol/l</i> -1 = nicht gemessen 997 = "low" 998 = "high" 999 = nicht messbar	
BlutzuckerEinheit	01 = mg/dl 02 = mmol/l	
Temperatur	Temperatur Messwert in Grad Celsius <i>Wertebereich = 20.0 bis 50.0</i> -1.0 = nicht gemessen 99.9 = nicht messbar	
Atmung1 Atmung2	Klinische Befunde Atmung -1 = nicht untersucht 00 = unauffällige Spontanatmung 01 = Dyspnoe 02 = Zyanose 03 = Spastik 04 = Rasselgeräusche 05 = Stridor 06 = Atemwegsverlegung 07 = Schnappatmung 08 = Apnoe 09 = Beatmung 10 = Hyperventilation 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Hautbefunde	Hautbefunde -1 = nicht untersucht 00 = unauffällig 01 = Kalt-Schweissigkeit 02 = Stehende Hautfalten 03 = Ödeme 04 = blass/fahl 05 = Dekubitus 06 = Exanthem/Erythem 07 = Marmorierung 08 = Ikterus 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
Psyche1 Psyche2	Psychischer Zustand -1 = nicht untersucht 00 = unauffällig 01 = aggressiv 02 = depressiv 03 = wahnhaft 04 = verwirrt 05 = verlangsamt 06 = manisch 07 = erregt 08 = ängstlich 09 = suizidal 10 = motorisch unruhig 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
Pupillenweite1 Pupillenweite2	Pupillenweite -1 = nicht untersucht 01 = beidseits eng 02 = beidseits mittelweit 03 = beidseits weit 04 = Anisokorie 05 = entrundet 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
Lichtreaktion1 Lichtreaktion2	Lichtreaktion -1 = nicht untersucht 00 = beidseits prompt 01 = beidseits träge 02 = beidseits keine 03 = Seitendifferenz 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
EtCO2Wert1 EtCO2Wert2	erster / letzter gemessener etCO ₂ Wert (unter Beatmung in mmHg gemessen) <i>Wertebereich = 0 bis 120</i> -1 = nicht gemessen 999 = nicht messbar	
Die nachfolgenden mit hellblauer Farbe markierten Felder betreffen nur Baden-Württemberg		
VBeatmung	Beatmung (außer Heimbeatmung) 01 = Ja 02 = Nein	
VBeatmungDetail	differenzierte Beatmung 01 = Ja 02 = Nein	
KatecholaminPflicht	Katecholaminpflichtigkeit 01 = Ja 02 = Nein	
KatecholaminTherapie	differenzierte Katecholamin-Therapie 01 = Ja 02 = Nein	
FortlaufendSedierung	fortlaufende Sedierung/Narkose 01 = Ja 02 = Nein	
VigilanzMinderung	deutliche Vigilanzminderung mit Einschränkung von Schutzreflexen 01 = Ja 02 = Nein	
InvasivBlutdruck	invasive Blutdruckmessung 01 = Ja 02 = Nein	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
SpezDevices	Spezielle Devices -1 = keine speziellen Devices eingesetzt 01 = Impella 02 = externer Schrittmacher 03 = IABP 04 = ECMO 98 = Sonstige	
AnzahlPerfusor	Anzahl der Perfusoren Einstellige numerische Angabe (0 bis 9)	
IndikationArztbegleitung	Indikation Arztbegleitung gegeben 01 = Ja 02 = Nein	
ZDringlichkeit	Zeitliche Dringlichkeit 01 = Notfall - schnellstmöglich, vitale Indikation 02 = dringlich - zeitnah, keine vitale Indikation 03 = planbar - Stunden oder Tage, nicht dringlich	
IndikationIT	Indikation Intensivtransport 00 = nein 01 = ja, Patientenzustand 02 = ja, intensivmedizinische Personalqualifikation erforderlich 03 = ja, medizintechnische Ausstattung der Regelrettung nicht ausreichend 98 = ja, Sonstiges	
Diagnose	ZNS Erkrankungen 1100 = Hirninfarkt, TIA, intrakranielle Blutung (1101 bis 1104) 1101 = TIA 1102 = Hirninfarkt 1103 = ICB (klin. Diagn.) 1104 = SAB (klin. Diagn.) 1105 = Krampfanfall 1106 = Fieberkrampf 1107 = Status Epilepticus 1108 = Meningitis - Encephalitis 1198 = sonstige Erkrankung ZNS	
	Herz/Kreislauf Erkrankungen 1201 = ACS 1202 = STEMI VW 1203 = STEMI HW 1204 = Thoraxschmerz unklarer Genese 1205 = Kardiogener Schock 1206 = tachykarde Rhythmusstörung 1207 = bradykarde Rhythmusstörung 1208 = PM-Fehlfunktion 1209 = ICD-Fehlfunktion 1210 = Lungenembolie 1211 = Herzinsuffizienz 1212 = Lungenödem 1213 = hypertensive Entgleisung 1214 = hypertensiver Notfall 1215 = Aortenaneurysma/-dissektion 1216 = Hypotonie 1217 = orthostatische Fehlregulation 1218 = Synkope 1219 = Thrombose/arterieller Verschluss 1220 = Herz-Kreislauf-Stillstand 1221 = hämorrhagischer Schock 1298 = sonstige Erkrankung Herz-Kreislauf	
	Atemwegserkrankungen 1301 = Asthma (Anfall) 1302 = Status Asthmaticus 1303 = exacerbierte COPD 1304 = Aspiration 1305 = Pneumonie/Bronchitis 1306 = Epiglottitis 1307 = Pseudokrupp 1308 = anderer respiratorischer Infekt 1309 = Hyperventilationssyndrom 1310 = Spontanpneumothorax 1311 = Hämoptysis 1312 = Dyspnoe unklarer Ursache 1398 = sonstige Erkrankung Atmung	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Diagnose	Abdominelle Erkrankungen 1401 = akutes Abdomen 1402 = obere GI Blutung 1403 = untere GI Blutung 1404 = Kolik (Galle, Niere,...) 1405 = (Infektiöse) Gastroenteritis 1406 = Mesenterialinfarkt 1498 = sonstige Erkrankung Abdomen	
	Psychiatrische Erkrankungen 1501 = Depression, Angst 1502 = Manie, Psychose 1503 = Entzugssymptomatik, Delir 1504 = Suizidalität 1505 = psychosoziale Krise 1598 = sonstige Erkrankung Psychiatrie	
	Störungen des Stoffwechsels sowie des Wasser- und Elektrolythaushalts 1601 = Hypoglykämie 1602 = Hyperglykämie 1603 = Urämie/ANV 1604 = Exsikkose 1605 = Elektrolytstörungen 1698 = sonstige Erkrankung Stoffwechsel	
	Gyn-/Geburtshilfe Notfälle 1701 = Schwangerschaft > 35. SSW (zur Entbindung in die Klinik) 1702 = Schwangerschaftskomplikation (z. B. Eklampsie) 1703 = Präklinische Geburt 1704 = Extrauterine Gravidität 1705 = vaginale Blutung 1798 = sonstige Erkrankung Gynäkologie	
	Sonstige Erkrankungen 1801 = Anaphylaxie Grad 1/2 1802 = Anaphylaxie Grad 3/4 1803 = Intoxikation Alkohol 1804 = Intoxikation Drogen 1805 = Intoxikation Medikamente 1806 = sonstige Intoxikation 1807 = akzidentelle Intoxikation 1808 = Sepsis/sept. Schock 1809 = Hochkontagiöse Erreger (SARS, HKLE,...) 1810 = sonstige Infektionserkrankungen 1811 = Hitzeerschöpfung, Hitzschlag 1812 = Unterkühlung/Erfrischung 1813 = SIDS 1814 = akute Lumbago 1815 = Palliative Situation 1816 = medizinische Behandlungskomplikation 1817 = Epistaxis/HNO-Erkrankung 1818 = urologische Erkrankung 1819 = Augenerkrankung 1820 = sonstiger akuter Schmerzzustand 1821 = Schock unklarer Genese 1822 = Erysipel 1898 = sonstige Erkrankung 1899 = führendes soziales Problem 9999 = keine Erkrankung/Verletzung feststellbar	
Diagnose	SHT 2001 = leicht 2002 = mittel 2003 = schwer 2004 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma Gesicht/Kopf/Hals 2101 = leicht 2102 = mittel 2103 = schwer 2104 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma HWS 2201 = leicht 2202 = mittel 2203 = schwer 2204 = lebensbedrohlich oder tödlich	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Diagnose	Trauma Thorax 2301 = leicht 2302 = mittel 2303 = schwer 2304 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma Abdomen 2401 = leicht 2402 = mittel 2403 = schwer 2404 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma BWS/LWS 2501 = leicht 2502 = mittel 2503 = schwer 2504 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma Becken 2601 = leicht 2602 = mittel 2603 = schwer 2604 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma obere Extremität 2701 = leicht 2702 = mittel 2703 = schwer 2704 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma untere Extremität 2801 = leicht 2802 = mittel 2803 = schwer 2804 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma Weichteile 2901 = leicht 2902 = mittel 2903 = schwer 2904 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma Gefäßverletzungen 2911 = leicht 2912 = mittel 2913 = schwer 2914 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Spezielle Traumata 3001 = Verbrennung/Verbrühung 3002 = Inhalationstrauma/Rauchgasinhalation 3003 = Elektrounfall 3004 = Verätzung 3005 = (Beinahe-) Ertrinken 3006 = Tauchunfall 3098 = Sonstige	
Verletzungsmuster	Verletzungsmuster 01 = Einzelverletzung 02 = Mehrfachverletzung 03 = Polytrauma (nach Tscherne)	
Unfallursache	Unfallursache 01 = Unfall 02 = Verdacht auf Gewaltanwendung 03 = Verdacht auf Suizid(versuch) 99 = nicht bekannt	
Unfallmechanismus	Unfallmechanismus 01 = stumpf 02 = penetrierend 03 = Amputation 99 = nicht bekannt	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Unfallhergang	Unfallhergang 01 = PKW-Insasse 02 = LKW-Insasse 03 = Bus-Insasse 04 = Motorradfahrer/-sozius 05 = Fahrrad 06 = unterstütztes Fahrrad (E-Bike/Pedelec) 07 = E-Scooter 08 = Fußgänger angefahren 09 = sonstiger Verkehrsunfall 10 = (Ab)Sturz mit Fallhöhe mehr als 3m (Kinder jünger als 2 Jahre: Fallhöhe mehr als 90cm, Kinder 2-14 Jahre: Fallhöhe mehr als 1,5m) 11 = (Ab)Sturz mit Fallhöhe maximal 3m (Kinder jünger als 2 Jahre: Fallhöhe maximal 90cm, Kinder 2-14 Jahre: Fallhöhe maximal 1,5m) 12 = ebenerdiger Sturz 13 = Schlagverletzung (Gegenstand, Ast,...) 14 = Schussverletzung 15 = Stichverletzung 16 = Gewaltverbrechen 17 = Explosion/Verpuffung (thermomech. Kombiverletzung) 18 = Verschüttung 19 = Arbeitsunfall 20 = Sportunfall 98 = andere Unfallarten 99 = nicht bekannt	
HelmPat	Helm Patient 00 = unbekannt 01 = Ja 02 = Nein	
NACAScore	NACA-Score 01 = geringfügige Störung 02 = ambulante Abklärung 03 = stationäre Behandlung 04 = akute Lebensgefahr nicht auszuschließen 05 = akute Lebensgefahr 06 = primär erfolgreiche Reanimation 07 = Tod 99 = nicht beurteilbar	
MNACAScore	M-NACA Score 02 = leichte Störung 03 = mäßige Störung 04 = drohende Lebensgefahr 05 = akute Lebensgefahr 06 = erfolgreiche Reanimation 07 = Biolog. Tod vorliegend - erfolglose Reanimation 99 = nicht errechenbar	
Airway	Airway Maßnahmen -1 = keine Maßnahmen durchgeführt 01 = Freimachen/Freihalten der Atemwege (z.B. Guedel/WendITubus)/Absaugen 02 = Maskenbeatmung unmöglich 03 = supraglott. Atemwegshilfe SGA 04 = Atemwegszugang erschwert 05 = Endotrachealtubus 06 = Intubation erschwert, mehr als 2 Versuche 07 = Koniotomie/chir. Atemweg 08 = Trachealkanülenwechsel 98 = Sonstige	
Atemunterst	Atemunterstützung - Beatmung -1 = keine Atemunterstützung durchgeführt 01 = Sauerstoffgabe (Sonde/Maske) 02 = manuell unterstützte Spontanatmung (Maske/Beutel) 03 = manuelle Beatmung bei fehlender Spontanatmung (Maske/Beutel) 04 = maschinell unterstützte Maskenbeatmung (NIV) 05 = maschinelle invasive Beatmung (unterstützt oder kontrolliert) 98 = Sonstige	
CirculationZugang	Medikamentenzugang -1 = kein Zugang gelegt 01 = PVK 02 = ZVK 03 = Shaldon- oder anderer großlumiger Katheter 04 = IO Punktion 97 = Zugang vorhanden/durch Andere 98 = Sonstige	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
SpezMassn	Spezielle Maßnahmen -1 = keine speziellen Maßnahmen durchgeführt 01 = Kühlung lokal 02 = Kühlung systemisch 03 = Wärmemanagement 04 = Entbindung 05 = Neugeborenenversorgung 06 = Krisenintervention 07 = Kardioversion 08 = Notfallnarkose 09 = Tourniquet 10 = Hämostyptica 11 = Thoraxdrainage/Entlastungspunktion 12 = Thorakotomie 13 = REBOA (resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta) 98 = Sonstige	
EKG12Kanal	12-Kanal-EKG -1 = kein 12-Kanal-EKG durchgeführt 01 = durch eigenes RM vor Ort 02 = durch Andere 03 = telemetrische Übermittlung an Zielklinik 04 = nicht durchführbar	
Medizintechnik	Medizintechnik -1 = keine Medizintechnik eingesetzt 01 = invasive RR-Messung 02 = ZVD 03 = ICP 04 = Ultraschall (Sono/Echo) 05 = Notfallpacer 06 = Spritzenpumpe(n) 07 = Videolaryngoskopie 08 = Transportinkubator 98 = Sonstige	
LagTrans	Lagerungs- und Rettungstechnik -1 = keine Lagerungs- und Rettungstechnik 01 = OK Hochlagerung 02 = Flachlagerung 03 = Schocklagerung 04 = stabile Seitenlage 05 = sitzender Transport 06 = Cervicalstütze/HWS-Immobilisation 07 = Spineboard 08 = Schaufeltrage 09 = Vakuummatratze 10 = (Extremitäten-)Schienung 11 = Reposition 12 = Verband 13 = Beckenschlinge 98 = Sonstige	
DurchfHeilkundlMassn	Eigenständig oder eigenverantwortlich durchgeführte heilkundliche Maßnahmen durch Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitäter 01 = ja, Medikamentengabe 02 = ja, Maßnahmen 03 = nein	
Behandlungspfad	diese Codes sind bundesland- und/oder regionalspezifisch	
Medikamentengabe	Erläuterung Applikationsformen: iv=intravenös, io=intraossär, im=intramuskulär, sc=subcutan, nl=intranasal, ih=inhalativ, po=oral, sl=sublingual/buccal, rl=rectal, td=transdermal Analgetika Fentanyl: 1001iv, 1001io, 1001im, 1001sc, 1001nl, 1001sl, 1001td Morphin: 1002iv, 1002io, 1002im, 1002sc, 1002nl, 1002po, 1002td Piritramid: 1003iv, 1003io, 1003im, 1003sc Sufentanil: 1004iv, 1004io, 1004nl, 1004sl anderes Opioid: 1005iv, 1005io, 1005im, 1005sc, 1005nl, 1005po, 1005sl, 1005rl, 1005td Metamizol: 1006iv, 1006io, 1006po Paracetamol: 1007iv, 1007io, 1007po, 1007rl Oxycodon: 1008iv, 1008io, 1008sc, 1008po, 1008sl Ketamin/Esketamin: 1009iv, 1009io, 1009im, 1009sc, 1009nl, 1009ih, 1009rl NSAID (z.B. Ibuprofen, Diclofenac): 1010iv, 1010io, 1010po, 1010rl Lokalanästhetikum (z.B. Lidocain): 1011sc, 1011td vorbehandelt mit Analgetika (sämtliche Applikationsformen): 1097xx sonstiges Analgetikum: 1098iv, 1098io, 1098im, 1098sc, 1098nl, 1098ih, 1098po, 1098sl, 1098rl, 1098td	

MIND 7.1 Codeliste	Release 1: 28.08.2026
Medikamentengabe	Antiarrhythmika Betablocker: 1101iv, 1101io, 1101po Amiodaron: 1102iv, 1102io, 1102po Adenosin: 1103iv, 1103io Atropin: 1104iv, 1104io Verapamil: 1105iv, 1105io 1105po Ajmalin: 1106iv, 1106io Digitalisglykosid: 1107iv, 1107io Lidocain: 1108iv, 1108io vorbehandelt mit Antiarrhythmika (sämtliche Applikationsformen): 1197xx sonstiges Antiarrhythmikum: 1198iv, 1198io, 1198im, 1198sc, 1198nl, 1198ih, 1198po, 1198sl, 1198rl, 1198td
	Antidota Flumazenil: 1201iv, 1201io, 1201nl Carbo medicinalis (Kohle): 1202po Naloxon: 1203iv, 1203io, 1203im, 1203sc, 1203nl Physostigmin: 1204iv, 1204io Atropin (als Antidot): 1205iv, 1205io Obidoxim: 1206iv, 1206io Hydroxocobalamin: 1207iv, 1207io Natriumthiosulfat: 1208iv, 1208io 4-Dimethylaminophenol (4-DMAP): 1209iv, 1209io Toloniumchlorid (Toluidinblau): 1210iv, 1210io Methylthioniniumchlorid (Methylenblau): 1211iv, 1211io vorbehandelt mit Antidota (sämtliche Applikationsformen): 1297xx sonstiges Antidot: 1298iv, 1298io, 1298im, 1298sc, 1298nl, 1298ih, 1298po, 1298sl, 1298rl, 1298td
	Antiemetika Dimenhydrinat: 1301iv, 1301io, 1301po, 1301rl Metoclopramid: 1302iv, 1302io, 1302po 5HT3 Antagonist (z. B. Ondansetron): 1303iv, 1303io, 1303po, 1303rl vorbehandelt mit Antiemetika (sämtliche Applikationsformen): 1397xx sonstiges Antiemetikum: 1398iv, 1398io, 1398im, 1398sc, 1398nl, 1398ih, 1398po, 1398sl, 1398rl, 1398td
	Sedativa/Antiepileptika Clonazepam: 1401iv, 1401io Diazepam: 1402iv, 1402io, 1402im, 1402sc, 1402po, 1402sl, 1402nl, 1402rl Lorazepam: 1403iv, 1403io, 1403im, 1403sc, 1403po, 1403sl, 1403nl, 1403rl Midazolam: 1404iv, 1404io, 1404im, 1404sc, 1404po, 1404sl, 1404nl, 1404rl Phenytoin: 1405iv, 1405io Levetiracetam: 1406iv, 1406io vorbehandelt mit Sedativa/Antiepileptika (sämtliche Applikationsformen): 1497xx sonstiges Sedativum/Antiepileptikum: 1498iv, 1498io, 1498im, 1498sc, 1498nl, 1498ih, 1498po, 1498sl, 1498rl, 1498td
	Antihypertensiva/Vasodilantien Urapidil: 1501iv, 1509io Glyceroltrinitrat: 1502iv, 1502io, 1502sl Clonidin: 1503iv, 1503io, 1503po vorbehandelt mit Antihypertensiva/Vasodilantien (sämtliche Applikationsformen): 1597xx sonstiges Antihypertensivum/Vasodilatans: 1598iv, 1598io, 1598im, 1598sc, 1598nl, 1598ih, 1598po, 1598sl, 1598rl, 1598td
	Bronchodilantien Salbutamol: 1601iv, 1601io, 1601ih Reproterol: 1602iv, 1602io, 1602ih Ipratropiumbromid: 1603iv, 1603io, 1603im, 1603sc, 1603ih Theophyllin: 1604iv, 1604io, 1604po vorbehandelt mit Bronchodilantien (sämtliche Applikationsformen): 1697xx sonstiges Bronchodilatans: 1698iv, 1698io, 1698im, 1698sc, 1698nl, 1698ih, 1698po, 1698sl, 1698rl, 1698td
	Diuretika Furosemid: 1701iv, 1701io vorbehandelt mit Diuretika (sämtliche Applikationsformen): 1797xx sonstiges Diuretikum: 1798iv, 1798io, 1798im, 1798sc, 1798nl, 1798ih, 1798po, 1798sl, 1798rl, 1798td
	Katecholamine/Vasopressoren Epinephrin: 1801iv, 1801io, 1801im, 1801sc, 1801nl, 1801ih Norepinephrin: 1802iv, 1802io Cafedrin/Theoadrenalin: 1803iv, 1803io Dobutamin: 1804iv, 1804io Vasopressin: 1805iv, 1805io vorbehandelt mit Katecholaminen (sämtliche Applikationsformen): 1897xx sonstige Katecholamine: 1898iv, 1898io, 1898im, 1898sc, 1898nl, 1898ih, 1898po, 1898sl, 1898rl, 1898td
	Kortikosteroide Dexametason: 1901iv, 1901io, 1901ih Methyl-/Prednisolon: 1902iv, 1902io, 1902ih, 1902rl vorbehandelt mit Kortikosteroiden (sämtliche Applikationsformen): 1997xx sonstiges Corticoid :1998iv, 1998io, 1998im, 1998sc, 1998nl, 1998ih, 1998po, 1998sl, 1998rl, 1998td

MIND 7.1 Codeliste	
Release 1: 28.08.2026	
Medikamentengabe	Muskelrelaxantien Suxamethonium: 2001iv, 2001io, 2001im Rocuronium 2002iv, 2002io vorbehandelt mit Muskelrelaxantien (sämtliche Applikationsformen): 2097xx sonstiges Muskelrelaxans: 2098iv, 2098io, 2098im, 2098sc, 2098nl, 2098ih, 2098po, 2098sl, 2098rl, 2098td
	Narkotika Etomidat: 2101iv, 2101io Propofol: 2102iv, 2102io Thiopental: 2103iv, 2103io vorbehandelt mit Narkotika (sämtliche Applikationsformen): 2197xx sonstiges Narkotikum: 2198iv, 2198io, 2198im, 2198sc, 2198nl, 2198ih, 2198po, 2198sl, 2198rl, 2198td
	Psychopharmaka Haloperidol: 2201iv, 2201io, 2201im Promethazin: 2202iv, 2202io, 2202im vorbehandelt mit Psychopharmaka (sämtliche Applikationsformen): 2297xx sonstige Psychopharmaka: 2298iv, 2298io, 2298im, 2298sc, 2298nl, 2298ih, 2298po, 2298sl, 2298rl, 2298td
	Antikoagulanzen UF Heparin: 2301iv, 2301io, 2301sc NM Heparin: 2302sc vorbehandelt mit Antikoagulanzen (sämtliche Applikationsformen): 2397xx sonstige Antikoagulanzen: 2398iv, 2398io, 2398im, 2398sc, 2398po
	TZ-Aggregationshemmer Acetylsalicylsäure: 2401iv, 2401io, 2401po Clopidogrel o.a.: 2402iv, 2402io, 2402po vorbehandelt mit TZ-Aggregationshemmern (sämtliche Applikationsformen): 2497xx sonstige TZ-Aggregationshemmer: 2498iv, 2498io, 2498im, 2498sc, 2498po, 2498sl
	Thrombolytika Tenecteplase: 2601iv, 2601io Alteplase: 2602iv, 2602io Reteplase: 2603iv, 2603io vorbehandelt mit sonstigen Thrombolytika (sämtliche Applikationsformen): 2697xx sonstiges Thrombolytikum: 2698iv, 2698io, 2698im, 2698sc
	Sonstige Medikamente Glukose: 2501iv, 2501io, 2501po H1 Blocker (z.B. Dimetinden): 2502iv, 2502io, 2502po H2 Blocker (z.B. Ranitidin): 2503iv, 2503io, 2503po Butylscopolamin: 2504iv, 2504io, 2504po Antibiotikum (z. B. Ceftriaxon): 2505iv, 2505io, 2505po Biperiden: 2506iv, 2506io, 2506po Oxytocin: 2507iv, 2507io, 2507nl Fenoterol (als Tokolytikum): 2508iv, 2508io, 2508ih Kaliumchlorid: 2509iv, 2509io, 2509po Calciumgluconat: 2510iv, 2510io 2510td Magnesiumsulfat: 2511iv, 2511io Insulin: 2512iv, 2512io, 2512sc Tranexamsäure: 2513iv, 2513io, 2513nl Natriumhydrogencarbonat: 2514iv, 2514io Erythrozytenkonzentrat: 2515iv, 2515io FFP: 2516iv, 2516io PPSB: 2517iv, 2517io Fibronogen: 2518iv, 2518io Lyoplasma: 2519iv, 2519io Thiamin: 2520iv, 2520io Simethicon: 2521po abschwellende Nasentropfen (z.B. Xylometazolin): 2522nl vorbehandelt mit sonstigen Medikamenten (sämtliche Applikationsformen): 2597xx sonstige Medikamente: 2598iv, 2598io, 2598im, 2598sc, 2598nl, 2598ih, 2598po, 2598sl, 2598rl, 2598td kein Medikament: 999999
Infusionsgabe	Kristalloide Infusionen Isotone Kochsalzlösung.: 3001iv, 3001io, 3001sc Vollelektrolytlösung: 3002iv, 3002io, 3002sc vorbehandelt mit Kristalloid (sämtliche Applikationsformen): 3097xx sonstiges Kristalloid: 3098iv, 3098io, 3098sc
	Spezielle Infusionen HÄS: 3101iv, 3101io SVR/Hyperosmol. NaCl: 3102 iv, 3102io Gelatine: 3103iv, 3103io vorbehandelt mit Kolloid (sämtliche Applikationsformen): 3197xx sonstige: 3198iv, 3198io, 3198 sc
	sonstige Angaben keine Infusion: 999999

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Neurologische Auffälligkeiten2	Akute neurologische Auffälligkeiten (ZNS, PNS) -1 = nicht untersucht 00 = keine 01 = Gesichtslähmung (kein Lächeln/hängender Mundwinkel) F 02 = Motorik Arme (einseitiges Absinken <10s/kein Anheben/keine Bewegung) A 03 = Motorik Beine (einseitiges Absinken <5s/kein Anheben/keine Bewegung) 04 = Sehstörung/Doppelbilder 05 = Sprachstörung (Aphasie)/Sprechstörung (Dysarthrie) S 06 = Schluckstörung 07 = Sensibilitätsstörung 08 = Gangunsicherheit/Schwindel 09 = Herdblick 10 = Übelkeit/Erbrechen 11 = Kopfschmerzen 12 = Meningismus 13 = Babinski Zeichen 14 = Querschnittssymptomatik 96 = gegenüber Erstbefund keine Änderungen 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
SoSiTransport	Sondersignal bei Transport: 01 = Ja 02 = Nein	
OrtPatUeberg	Ort Patienten-Übergabe 01 = ZNA/INA/PINA 02 = INZ/KINZ 03 = Schockraum 04 = Intensivstation 05 = Allgemeinstation 06 = Herzkatheterlabor (HKL) 07 = Stroke Unit 08 = CT 09 = OP direkt 10 = Fachambulanz 11 = Chest Pain Unit (CPU) 12 = Kreissaal 13 = Arztpraxis 14 = Notfall-/Bereitschaftspraxis 15 = Einsatzstelle 98 = Sonstige	
NummerZK	Kennung der Zielklinik: 000001001 bis 000009990 = ID aus Krankenhausverzeichnis (Transportziele) für die Datenlieferung an die SQR-BW 770000000 bis 779999999 = Standortnummer 000009998 = sonstige Zielklinik 000009999 = anderes Transportziel (z.B. Arztpraxis)	
AnmeldungPatient	Patient in Zielklinik angemeldet 01 = Ja 02 = Nein	
Einsatzbesonderheiten	Einsatzbesonderheiten 00 = keine 01 = nächste geeignete Klinik nicht aufnahmebereit 02 = Pat. lehnt indizierte Maßnahmen ab 03 = bewusster Therapieverzicht 04 = indizierte Maßnahme aufgrund Kontraindikation nicht durchgeführt 05 = Infektionstransport (mit Desinfektionsmaßnahmen) 06 = aufwendiger Infektionstransport - über die reguläre Ausstattung hinausgehende Infektionsschutzmaßnahmen/-ausrüstung erforderlich 07 = Schwerlasttransport 08 = Zwangsunterbringung 09 = aufwendige technische Rettung 10 = Einsatz mit LNA/OrgL 11 = mehrere Patienten 12 = MANV 13 = kein Notarzt in angemessener Zeit verfügbar 14 = erschwerter Patientenzugang 15 = verzögerte Patientenübergabe 16 = Gewalt gegen Einsatzkräfte 17 = Wahl der Zielklinik durch Dritte (z.B. HA, Klinikarzt,...) 18 = Wahl der Zielklinik verursacht durch Patientenwunsch 19 = Einsatzabbruch (dieses Einsatzes) wegen Folgeeinsatz 20 = dieser Einsatz ist ein Folgeeinsatz 98 = Sonstige	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
PreEmergencyStatus	Zustand vor Eintritt des Notfalls 01 = ohne Vorerkrankungen (VE) 02 = VE ohne nennenswerte Einschränkung des tgl. Lebens 03 = VE mit nennenswerter Einschränkung des tgl. Lebens 04 = normales tgl. Leben unmöglich 05 = Pat. wird in den nächsten 24 Std. sterben, mit und ohne medizinische/-r Hilfe 99 = nicht bekannt	
Reanimationssituation	Lag eine Reanimationssituation vor / wurde von der Rettungsmittelbesatzung eine Reanimation begonnen? 00 = keine Reanimationssituation (kein Tod/kein Kreislaufstillstand) 01 = Reanimation durchgeführt durch dokumentierendes Rettungsmittel 02 = Reanimation durchgeführt und aufgrund nachträglicher Erkenntnis über fehlendes Therapieziel eingestellt 03 = Reanimation durchgeführt und aufgrund nachträglicher Erkenntnis über mutmaßlichen Patientenwillen eingestellt 04 = Reanimation durch Andere durchgeführt mit fortbestehendem ROSC bei eigenem Eintreffen 05 = Reanimation nicht durchgeführt, weil sichere Todeszeichen 06 = Reanimation nicht durchgeführt, aufgrund mutmaßlichen Patientenwillens (z.B. DNR-Order) 07 = Reanimation nicht durchgeführt, weil aussichtslose Grunderkrankung bekannt 08 = Reanimation nicht durchgeführt, wegen aussichtsloser sonstiger Faktoren (z.B. Zeit überschritten)	
Reanimationstechnik	Reanimationstechnik -1 = keine 01 = Einsatz eines public access AED 02 = Einsatz eines feedback-Systems 03 = Mechanisches Thoraxkompressionsgerät 04 = extrakorporale CPR (eCPR)	
URKRSTST	Vermutete Ursache des Kreislaufstillstandes 01 = kardial 02 = Trauma 03 = Ertrinken 04 = Hypoxie 05 = Intoxikation 06 = ICB/SAB 07 = SIDS 08 = Verbluten 09 = Stroke 10 = metabolisch 11 = Sepsis 12 = Anaphylaxie 13 = Stromschlag 97 = sonstiges nicht medizinisch 98 = sonstiges medizinisch 99 = nicht bekannt	
SPORT	Zusammenhang mit sportlicher Aktivität: 01 = Ja 02 = Nein	
ZCKB	Kollaps beobachtet durch -1 = nicht beobachtet 01 = Ersthelfende 02 = aktivierte Ersthelfende (z.B. App-Ersthelfende) 03 = First Responder 04 = KTW-Besatzung 05 = RTW-Besatzung 06 = NA-Rettungsmittel 98 = Sonstige 99 = nicht bekannt	
ZCHDM	Beginn der Herzdruckmassage durch -1 = keine Herzdruckmassage durchgeführt 01 = Ersthelfende 02 = aktivierte Ersthelfende (z.B. App-Ersthelfende) 03 = First Responder 04 = KTW-Besatzung 05 = RTW-Besatzung 06 = NA-Rettungsmittel 98 = Sonstige 99 = nicht bekannt	
ZCDEFI	Erste Defibrillation durch -1 = keine Defibrillation durchgeführt 01 = Ersthelfende 02 = aktivierte Ersthelfende (z.B. App-Ersthelfende) 03 = First Responder 04 = KTW-Besatzung 05 = RTW-Besatzung 06 = NA-Rettungsmittel 98 = Sonstige 99 = nicht bekannt	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
ROSC	Erreichen eines Spontankreislaufs (ROSC) 01 = niemals ROSC 02 = jemals ROSC	
KHAUF	Patientenzustand bei Krankenhausaufnahme 01 = keine Krankenhausaufnahme, Tod an der Einsatzstelle 02 = Krankenhausaufnahme mit ROSC 03 = Krankenhausaufnahme unter laufender Reanimation	

4. Exporthinweise MIND

MIND 7.1 Exporthinweise		Release 1: 28.08.2026
Kapitel-/Feldname	Besondere Hinweise für Baden-Württemberg	Exporthinweise an Hersteller
Wichtig: Im MIND werden Pflichtfelder von optionalen Feldern unterschieden. Bei Pflichtfeldern wird im Datensatz immer ein gültiger Eintrag, entsprechend der in der Spalte „Bezeichnung Merkmal Ausprägung“ definierten Feldinhalte, erwartet. Ein Datensatz kann nicht abgeschlossen und exportiert werden, wenn nicht alle Pflichtfelder mit einem gültigen Eintrag versehen sind. Bei den Pflichtfeldern werden zwei unterschiedliche Pflichtbedingungen unterschieden: Generelle Pflichtfelder sind immer und ohne weitere Abhängigkeiten für jeden Datensatz Pflicht. Dies kann für ein einzelnes Datenfeld oder für ein gesamtes Kapitel gelten, sie sind in der Spalte Pflicht durch ein "Ja" gekennzeichnet. Pflichtfelder, die in Abhängigkeit der Inhalte anderer Felder zur Pflicht werden, sind in der Spalte Pflicht durch "siehe Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten" gekennzeichnet, die Abhängigkeiten selbst sind jeweils in der korrespondierenden Zelle der Spalte "Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten" definiert. Für den Export müssen alle MIND-Felder mit Inhalten versehen sein. Wurde in einem optionalen Feld ein Inhalt dokumentiert, der einem im Datensatz definierten Feldinhalt entspricht und damit XSD-konform ist, muss dieser Inhalt entsprechend exportiert werden. Leere optionale Felder, bei denen der Nutzer keinen Wert eingetragen hat, müssen mit dem technischen Default (letzte Spalte im Tabellenblatt Datenfelder_MIND) befüllt werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass ein vom Nutzer eingetragener Inhalt nicht durch den technischen Default überschrieben wird. Die technischen Defaults dürfen nicht in Felder eingetragen werden, für die eine Pflichtbedingung formuliert ist.		
Kapitel: Strukturdaten		
Protokolltyp		Typ des verwendeten Teildatensatzes NA – Notarztdokumentation: NA-Projekt-ID, NA-Einsatzart, NA-Rettungsmittel, NA-Qualifikation, Fachgebiet NA RD – Rettungsdienstdokumentation: RD-Projekt-ID, RD-Einsatzart, RD-Rettungsmittel, RD-Qualifikation
Standortkennung*		
ProjektID	Wird von der SQR-BW bei der Standortregistrierung vergeben und den NA-Standortleitern/RDL mitgeteilt. Die Verwendung der korrekten ProjektID ist essenziell für die korrekte Zuordnung von Rettungsmittel(n) zum Standort!	Soll beim Export automatisch eingetragen werden.
Leitstelle	Landkreiskennung der Heimatleitstelle wird von der SQR-BW vergeben und steht unter www.sqrbw.de in der Infothek zur Verfügung (Leitstellenkennung).	Soll beim Export automatisch eingetragen werden.
Softwarekennung	Pflicht in Baden-Württemberg. Zu verwendendes Softwarehersteller-Kürzel muss initial bei der SQR-BW angefordert werden.	Soll beim Export automatisch eingetragen werden. Identifikation des Dokumentationssystems und der Softwareversion.
Kapitel: RettungstechnischeDaten		

Primaerschluessel	DER PRIMÄRSCHLÜSSEL IST DIE AUFTRAGSNUMMER DER HEIMATLEITSTELLE! (Heimatleitstelle ist die für den RDB zuständige Leitstelle, in dem das Rettungsmittel seinen Standort hat). Hinweis: Nicht zu verwechseln mit der Auftragsnummer ist die Einsatznummer. Unter dieser werden die Auftragsnummern mehrerer Rettungsmittel und/oder Patienten innerhalb eines Einsatzes zusammengefasst.	
EinsatzArt	Wenn ein RTW ersatzweise einen Krankentransport durchführt, ist dies mit 10 (und nicht 04 bzw. 08) zu dokumentieren. Um sicherzustellen, dass Sekundäreinsätze bei bestimmten Indikatorberechnungen ausgeschlossen werden, ist es erforderlich, dass diese unter EinsatzArt als "Verlegung" [oder Intensivtransport] dokumentiert werden.	
Gemeindeschlüssel*		
Postleitzahl*		
GeoEinsatzort		Geokoordinaten des Einsatzortes im Dezimalformat [WGS 84]. Die Koordinaten werden in der Reihenfolge Breitengrad, Längengrad mit Komma getrennt angegeben. Format: 99.999999,99.999999
EinsatzortTyp		
RDTransport		
AerztlBegleit		
NotarztNachgefordert		
TNANachgefordert		
KeinTranspMitPat		
KeinTranspOhnePat		
DokRM	Sofern ein RTW einen Krankentransport durchführt, ist hier trotzdem der Code 02 (RTW) zu wählen. Für Krankentransporte, die von KTW durchgeführt werden, ist kein Datensatzexport an die SQR-BW vorzunehmen.	
BeteilRM	keine Relevanz und damit auch keine Befüllung für BW, da diese Information den Leitstellen-Daten entnommen wird	das Feld soll in Abhängigkeit vom Feld "Dokumentierendes RM" vorbelegt werden (dokumentierendes RM soll automatisch in "beteiligte RM" übernommen werden)

AerztQualifikation		Wert aus Codetabelle kann beim Export automatisch erzeugt werden, beispielsweise durch Zugriff auf Stammdatenbank (Personalnummer o.ä.).
StatusPersonal		
Kapitel: ZeitenEinsatzablauf		
Einsatzdatum		
SymptombeginnVor24h		
Symptombeginn		Angabe von Datum und Zeit (Formattyp xs:dateTime).
SymptombeginnGesichert		
ZeitNotfallmeldung*		Formattyp xs:dateTime
ZeitAlarm*		Formattyp xs:dateTime
ZeitAusruecken*		Formattyp xs:dateTime
ZeitAnkunftEinsatzort*		Formattyp xs:dateTime
ZeitAnkunftPatientPatientenkontakt		Formattyp xs:dateTime
ZeitTransportbeginn*		Formattyp xs:dateTime
ZeitEintreffenTransportziel*		Formattyp xs:dateTime
ZeitUebergabePatient		Formattyp xs:dateTime
ZeitEinsatzende		Formattyp xs:dateTime
Kapitel: Patientendaten		
Alter		
ValiditaetAlter		
Geschlecht		
Kapitel: ErsteMesswerteUndBefunde		
Bewusstsein1		
GlasgowComaScale1		
NeurologischeAuffaelligkeiten1		
SystolischerBlutdruck1		
EKGBefund1		
Herzfrequenz1		Wird hier kein gültiger Wert dokumentiert, muss eine erhobene Pulsfrequenz exportiert werden.
Atemfrequenz1		
Sauerstoffsattigung1		
Rekapillarierungszeit		
Schmerzempfinden1		
Schmerzerleben		

Blutzuckerwert1		Der erste im Einsatzverlauf dokumentierte Wert aus dem Wertebereich (0 bis 900 bzw. 0.0 bis 50.0) bzw. "997 = low", "998 = high" oder "999 = nicht messbar" muss exportiert werden, auch wenn zuvor "-1 = nicht gemessen" angegeben wurde.
BlutzuckerEinheit	In BW ist - sofern erforderlich - hier der Defaultwert 01 (=mg/dl) zu setzen	
Temperatur		Der erste im Einsatzverlauf dokumentierte Wert aus dem Wertebereich (20.0-50.0) oder "99.9 = nicht messbar" muss exportiert werden, auch wenn zuvor "-1.0 = nicht gemessen" angegeben wurde.
Atmung1		
Hautbefunde		
Psyche1		
Pupillenweite1		Sofern die Möglichkeit einer seitengetrenten Befunddokumentation auf dem Pad angeboten wird, ist diese bei beidseitiger gleicher Ausprägung mit den Codes 01 bis 03 (beidseits gleich) bzw. bei seitengetrenter Ausprägung mit dem Code 04 (Anisokorie) zu exportieren
Lichtreaktion1		Sofern die Möglichkeit einer seitengetrenten Befunddokumentation auf dem Pad angeboten wird, ist diese bei beidseitiger gleicher Ausprägung mit den Codes 00 bis 02 (beidseits prompt, träge, keine) bzw. bei seitengetrenter Ausprägung mit dem Code 03 (Seitendifferenz) zu exportieren
EtCO2Wert1		Der erste im Einsatzverlauf dokumentierte Wert aus dem Wertebereich (00-120) oder "999 = nicht messbar" muss exportiert werden, auch wenn zuvor "-1 = nicht gemessen" angegeben wurde.
Kapitel: ErstbefundeVerlegung	Kapitel nur in Baden-Württemberg relevant	
VBeatmung		
VBeatmungDetail		
KatecholaminPflicht		
KatecholaminTherapie		
FortlaufendSedierung		
VigilanzMinderung		
InvasivBlutdruck		

SpezDevices	Bei Auswahl von Sonstige (Code 98) muss ein Freitextfeld dazu ausgefüllt werden - nur wenn dieses befüllt wurde, ist die Auswahl valide	
AnzahlPerfusor		Bei Angabe größer 9: Export von Wert 9
Kapitel: EinschätzungVerlegungsarzt	Kapitel nur in Baden-Württemberg relevant	
IndikationArztbegleitung		
ZDringlichkeit		
IndikationIT	Bei Auswahl von Sonstige (Code 98) muss ein Freitextfeld dazu ausgefüllt werden - nur wenn dieses befüllt wurde, ist die Auswahl valide	
Kapitel: Diagnosen		
Diagnose	Jede hier dokumentierte Diagnose wird als Notfalldiagnose betrachtet und für die Indikatorberechnung als relevant angesehen.	• Jede Diagnose nur einmal exportieren. • Diagnosen mit der Zusatzkennung "Z.n." (Zustand nach) dürfen nur exportiert werden, wenn es sich um die einzige vorhandene Diagnose handelt.
Kapitel: VerletzungenDetails		
Verletzungsmuster		
Unfallursache		
Unfallmechanismus		
Unfallhergang		
HelmPat		
Kapitel: Scores		
NACAScore		
MNACAScore	Wird durch SQR-BW berechnet. Erläuterung im Dokument "Ermittlung des M-NACA" auf www.sqrbw.de einzusehen.	Ermittlung gemäß M-NACA Berechnungsschema.
Kapitel: RDMassnahmen		
Airway		
Atemunterst		
CirculationZugang		
SpezMassn		
EKG12Kanal		
Medizintechnik		
LagTrans		
DurchfHeilkundlMassn	in BW sind SAA/BPR gemeint	
Behandlungspfad	<i>aktuell können zu diesem Feld noch keine inhaltlichen Festlegungen getroffen werden</i>	<i>aktuell können zu diesem Feld noch keine inhaltlichen Festlegungen getroffen werden</i>
Kapitel: MedikamentöseTherapie		

Medikamentengabe		Bei mehrfacher Gabe des gleichen Medikamentes nur einmaliger Export des entsprechenden Codes. Nicht alle am Markt verfügbaren Medikamente können in den hinterlegten Medikamentenlisten gepflegt werden. Daher kann es vorkommen, dass nicht hinterlegte Medikamente Bestandteil einer Notfallbehandlung darstellen, diese sollten daher auch dokumentiert werden können. Daher wurde für jede Medikamentengruppe ein Code **98** (sonstige) definiert. Für jede Medikamentengruppe sollte daher in der Medikamentenliste auch eine Auswahl "sonstige" ermöglicht werden. Aus forensischen Gründen empfehlen wir jedoch dringend, dass dem Anwender für die Auswahl eines Codes **98** (sonstige) aus irgendeiner Medikamentengruppe ein Freitextfeld zur Verfügung gestellt wird, in dem er das verabreichte Medikament mit Klarnamen dokumentieren kann.
Infusionsgabe		Bei mehrfacher Gabe der gleichen Infusionslösung nur einmaliger Export des entsprechenden Codes.
Kapitel: AbschlussBefundeBT		
Bewusstsein2		
GlasgowComaScale2		
NeurologischeAuffaelligkeiten2		
SystolischerBlutdruck2		
EKGBefund2		
Herzfrequenz2		Wird hier kein gültiger Wert dokumentiert, muss eine erhobene Pulsfrequenz exportiert werden.
Atemfrequenz2		
Sauerstoffsättigung2		
Schmerzempfinden2		
Atmung2		
Psyche2		
Pupillenweite2		Sofern die Möglichkeit einer seitengetrenten Befunddokumentation auf dem Pad angeboten wird, ist diese bei beidseitiger gleicher Ausprägung mit den Codes 00 bis 02 (beidseits prompt, träge, keine) bzw. bei seitengetrenter Ausprägung mit dem Code 04 (Anisokorie) zu exportieren

Lichtreaktion2		Sofern die Möglichkeit einer seitengetrennten Befunddokumentation auf dem Pad angeboten wird, ist diese bei beidseitiger gleicher Ausprägung mit den Codes 01 bis 03 (beidseits gleich) bzw. bei seitengetrennter Ausprägung mit dem Code 03 (Seitendifferenz) zu exportieren
SoSiTransport		
OrtPatUeberg		
Kapitel: AbschlussBefundeBTAV		
Blutzuckerwert2		Der letzte im Einsatzverlauf dokumentierte Wert aus dem Wertebereich (0 bis 900 bzw. 0.0 bis 50.0) bzw. "997 = low", "998 = high" oder "999 = nicht messbar" muss exportiert werden, auch wenn danach "-1 = nicht bestimmt" angegeben wurde.
EtCO2Wert2		Der letzte im Einsatzverlauf dokumentierte Wert aus dem Wertebereich (00-90) oder "99 = nicht messbar" muss exportiert werden, auch wenn danach "-1 = nicht gemessen" angegeben wurde.
Kapitel: Zielklinik		
NummerZK	Bei Notarzteinsätzen sollte im Notarztprotokoll immer das Transportziel dokumentiert werden, auch wenn der Transport ohne notärztliche Begleitung erfolgt, da die Entscheidung über das Transportziel in notärztlicher Verantwortung liegt. Dies ist relevant für die Indikatorberechnung der SQR-BW. In BW soll anstelle der Standortnummer weiterhin die 4-stellige Klinik-ID der SQR-BW mit führenden Nullen von 000001000 bis 000009900 geliefert werden. (zu finden unter https://www.sqrbw.de/sqr-bw/infothek)	
AnmeldungPatient		
Kapitel: EinsatzBesonderheiten		
Einsatzbesonderheiten	Um eine ungewollte Berücksichtigung bei der Indikatorberechnung zu vermeiden, müssen falls zutreffend folgende Einsatzbesonderheiten hier dokumentiert werden: • Pat. lehnt indizierte Maßnahmen ab • bewusster Therapieverzicht • nächste geeignete Klinik nicht aufnahmebereit	
PreEmergencyStatus		
Kapitel: Reanimation		
Reanimationssituation		

Kapitel: ReanimationDetails		
Reanimationstechnik		
URKRSTST		
SPORT		
ZEOFR		Formattyp xs:dateTime
ZCKB		Formattyp xs:dateTime
ZCHDM		Formattyp xs:dateTime
ZCDEFI		Formattyp xs:dateTime
ZHDM		Formattyp xs:dateTime
ZDEFI1		Formattyp xs:dateTime
ZROSC1		Formattyp xs:dateTime
ROSC		
KHAUF		
ZTOD		Formattyp xs:dateTime
Ende		
* Die grau hinterlegten Felder müssen nicht übermittelt werden, wenn die Informationen leitstellenseitig zur Verfügung stehen. Sie sind im Datensatz enthalten, da diese Möglichkeit nicht in allen Bundesländern zur Verfügung steht.		

DIV-NOTFALLEINSATZ-DATENSATZSCHRIBUNG 7.1 WIND-DATENSATZSCHRIBUNG 7.1 Zeichensatz in einer bestimmten D.A. (Einsatz) und ausschließlich für das DIV-Nachrichtensystem relevant	Pflicht (je falls basieren auf das zugeworfte Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugehörigkeit DIV-MIND	Einfach Mehrfach E/M	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	MIND- Tabellensatz Notiert (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Pauschibilisierungsregeln	techn. Status MIND
Notlage	siehe Hinweis Pauschibilisierungs- Abhängigkeiten	Rettungstechnische Daten	Einsatzverlauf	DM	M	Notlage Bezeichnung Wertliste siehe Tabellenstat Codes	NA + RD	Wurde der Transport selbst begleitet? Wenn ja, von wem? Pflicht für NA- und RD-Protokolle bei Einsätzen mit durchgeführten Transport Bei gemeinsamen Einsatz von RTW und NA überliche Dokumentation in RD- und NA-Protokoll	Tagefreigeist für Dokumentationsumfang und Pauschibilisierungsregeln Pflicht wenn: RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) Kombinationen mit 00 sind unzulässig	-2
Notlageaufgefordert	siehe Hinweis Pauschibilisierungs- Abhängigkeiten	Rettungstechnische Daten	Einsatztechnische Daten	DM	E	Physikalischer Notlage wurde nachgefordert Wertliste siehe Tabellenstat Codes	NA + RD	Betrifft nur die Nachforderung eines physikalischen Notlages (nicht eines Informationslages) NA: Wurden Sie nachgefordert? RD: Haben Sie einen Notlage nachgefordert? Falls unbekannt: "nein" dokumentieren Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseninsätze wenn bei Protokoll RD eine Einsatzart angegeben wurde, die eine primäre Alarmierung eines (physikalischen) NA zum Ausdruck bringt (01, 03, 05, oder 07), ist die Dokumentation Notlageaufgefordert unzulässig	Tagefreigeist für Dokumentationsumfang und Pauschibilisierungsregeln Pflicht wenn: EinsatzNA NICHT (11 ODER 12) Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND EinsatzNA GLEICH (01 ODER 03 ODER 05 ODER 07), dann ist Notlageaufgefordert = 01 unzulässig	-2
Notlageaufgefordert	siehe Hinweis Pauschibilisierungs- Abhängigkeiten	Rettungstechnische Daten	Einsatztechnische Daten	DM	E	Falsch-Notlage wurde nachgefordert Wertliste siehe Tabellenstat Codes	NA + RD	Betrifft nur die Nachforderung eines Informationslages (nicht eines physikalischen Notlages) NA/RD: Haben Sie einen NA nachgefordert? Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseninsätze wenn bei Protokoll RD eine Einsatzart angegeben wurde, die eine primäre Alarmierung eines NA zum Ausdruck bringt (03, 05, oder 07) ist die Dokumentation Notlageaufgefordert unzulässig	Tagefreigeist für Dokumentationsumfang und Pauschibilisierungsregeln Pflicht wenn: EinsatzNA NICHT (11 ODER 12) Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND EinsatzNA GLEICH (02 ODER 03 ODER 06 ODER 07), dann ist Notlageaufgefordert = 01 unzulässig	-2
Notlageaufgefordert	siehe Hinweis Pauschibilisierungs- Abhängigkeiten	Rettungstechnische Daten	Einsatztransport	DM	E	Grund für Einsatz ohne Transport trotz Patientenkontakt Wertliste siehe Tabellenstat Codes	NA + RD	Pflicht für Einsätze ohne Transport trotz Patientenkontakt nur für Einsätze ohne Transport, aber <u>ggf</u> Patientenkontakt <u>ggf</u> für Einsätze ohne Patientenkontakt (diese sollen unter KeinTransport dokumentiert werden) 02 = primäre Transportaufstellung (ohne OPF) (ohne Transportaufstellungen ohne Reanimation (Einsätze sind erforderlich, Abschlussbefunde/Diagnose/RD-Maßnahmen sind nicht erforderlich.) Der Grund für die nicht durchgeführte Reanimation muss in Feld Reanimationsmaßnahmen angegeben werden! Sollte Reanimationsmaßnahmen durchgeführt werden, darf in Feld KeinTransport <u>ggf</u> die 02 ausgewählt werden und in Feld Reanimationsmaßnahmen muss 01 oder 02 oder 03 gewählt werden. Erfolgreiche Reanimationen werden mit dem Code 03 = Patient in Einsatzverlauf verstorben dokumentiert. Wenn Reanimationsmaßnahmen durch andere erfolgen und bei Eintreffen des eigenen RM der RSCG fortgesetzt, darf in Feld KeinTransport <u>ggf</u> die 02 ausgewählt werden und in Feld Reanimationsmaßnahmen muss 04 gewählt werden. Die Dokumentation über das Vorliegen eines Einsatzes ohne Transport trotz stattgehabtem Patientenkontakt erfolgt in Kombination mit dem Feld RDTransport (01 = kein Patiententransport, bzw. Patientenkontakt)	Tagefreigeist für Dokumentationsumfang und Pauschibilisierungsregeln Pflicht wenn: RDTransport GLEICH 01 Wenn RDTransport NICHT 01, sind sämtliche Inhalte in KeinTransport auf -2 unzulässig	-2
Notlageaufgefordert	siehe Hinweis Pauschibilisierungs- Abhängigkeiten	Rettungstechnische Daten	Einsatzverlauf	DM	E	Sind für Einsatz ohne Transport, da kein Patientenkontakt Wertliste siehe Tabellenstat Codes	NA + RD	Pflicht für Einsätze ohne Transport wegen fehlenden Patientenkontakt nur für Einsätze ohne Patientenkontakt <u>ggf</u> für Einsätze mit Patientenkontakt ohne Patiententransport (diese müssen unter KeinTransport dokumentiert werden) Die Dokumentation über das Vorliegen eines Einsatzes ohne Transport aufgrund fehlenden Patientenkontakts erfolgt in Kombination mit dem Feld RDTransport (02 = kein Patiententransport, da kein Patientenkontakt)	Tagefreigeist für Dokumentationsumfang und Pauschibilisierungsregeln Pflicht wenn: RDTransport GLEICH 02 Wenn RDTransport NICHT 02, sind sämtliche Inhalte in KeinTransport auf -2 unzulässig	-2
Notlageaufgefordert	Ja	Rettungstechnische Daten	Einsatztechnische Daten	DM	E	Rettungsmitteltyp des dokumentierenden Rettungsmittels Wertliste siehe Tabellenstat Codes	NA + RD	Dokumentation des Rettungsmitteltyps, welches den Einsatz abwickelt und dokumentiert. Wird in der Regel durch die Lokale dokumentiert.	Wenn Protokolltyp NA dann sind DADRUM GLEICH (02 ODER 03 ODER 10 ODER 11 ODER 12 ODER 15 ODER 17 ODER 18 ODER 20) unzulässig Wenn Protokolltyp RD dann sind DADRUM GLEICH (01 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 13 ODER 14 ODER 16 ODER 19) unzulässig	-2
Notlageaufgefordert	Nein	Rettungstechnische Daten	Einsatztechnische Daten	DM	M	Rettungsmitteltyp des beschrifteten Rettungsmittels Wertliste siehe Tabellenstat Codes	NA + RD	Dokumentation der an Einsatz beteiligten Rettungsmittel Wird in der Regel durch die Lokale dokumentiert.	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen. Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	-2
Notlageaufgefordert	siehe Hinweis Pauschibilisierungs- Abhängigkeiten	Rettungstechnische Daten	Einsatztechnische Daten	DM	M	Fachrichtung/Qualifikation des Notlages/Transportdienstes Wertliste siehe Tabellenstat Codes	NA	Pflicht für NA-Protokolle, außer für Dienstfahrten oder Pauseninsätze Es ist immer die Fachrichtung/Qualifikation des dokumentierenden Arztes einzutragen	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND EinsatzNA NICHT (11 ODER 12)	-2
Notlageaufgefordert	siehe Hinweis Pauschibilisierungs- Abhängigkeiten	Rettungstechnische Daten	Einsatztechnische Daten	DM	E	Status des Personals Wertliste siehe Tabellenstat Codes	NA + RD	Klassifikation des höchstqualifizierten Mitarbeiters auf dem Rettungsmittel. Wenn mindestens ein Rettungsmittel des Notlages, kein sonstiges Rettungsmittel, das das Rettungsmittelpersonal bezieht. Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseninsätze	Pflicht wenn: EinsatzNA NICHT (11 ODER 12)	-2
Notlageaufgefordert	Nein	Einsatztechnische Daten	Einsatztechnische Daten	D	E	Notlage-Zustand Wertliste siehe Tabellenstat Codes 200		Bei Einsätzen in Ortschaften Ortschaft, sonst Bezeichnung der Straße (z.B. B408, B16) oder Name der Gemarkung (z.B. Chemnitz)	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Notlageaufgefordert	Nein	Einsatztechnische Daten	Einsatztechnische Daten	D	E	Notlage-Zustand Wertliste siehe Tabellenstat Codes 200		Bei Einsätzen in Ortschaften Ortschaft, sonst Wegkürzel der Straße (z.B. Stockholmer 122) oder andere beim Bezeichnung (z.B. Gabel)	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Notlageaufgefordert	Nein	Einsatztechnische Daten	Einsatztechnische Daten	D	E	Notlage-Zustand Wertliste siehe Tabellenstat Codes 200		Ja, wenn der Moment des Notlages/ der Synkope/ das akute Ereignisses von Unfallschaden beabsichtigt wurde. Nicht ausgeführt wird wie kein behandelt	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Notlageaufgefordert	Nein	Einsatztechnische Daten	Einsatztechnische Daten	D	E	Notlage-Zustand Wertliste siehe Tabellenstat Codes 200		Ja, wenn Transporter/Transportmittel zu primären Transporten ein Einsatz angenommen eine nicht ausgesetzt wird gewarnt Klassifikation des Personals	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Notlageaufgefordert	Nein	Einsatztechnische Daten	Einsatztechnische Daten	D	E	Notlage-Zustand Wertliste siehe Tabellenstat Codes 200		Kurze Name des Notlages, ggf. mit Vorname und Titel	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Notlageaufgefordert	Nein	Einsatztechnische Daten	Einsatztechnische Daten	D	E	Notlage-Zustand Wertliste siehe Tabellenstat Codes 200		Kurze Name des Notlages, ggf. mit Vorname und Bezeichnung	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Notlageaufgefordert	Nein	Einsatztechnische Daten	Einsatztechnische Daten	D	M	Notlage-Zustand Wertliste siehe Tabellenstat Codes 200		Ggf. weitere Transportmittel, wenn es notwendig ist	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Notlageaufgefordert	Nein	Einsatztechnische Daten	Einsatztechnische Daten	D	M	Notlage-Zustand Wertliste siehe Tabellenstat Codes 200		Rufname des Fahrzeuges, dessen Einsatz hier dokumentiert wird. Steigt der dokumentierende Notlage um, so werden bei beiden Rufnamen angegeben	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Notlageaufgefordert	Nein	Einsatztechnische Daten	Einsatztechnische Daten	D	E	Notlage-Zustand Wertliste siehe Tabellenstat Codes 200		Person, wenn in gegebenem Fall kein Patient behandelt werden konnte bzw. warum ein anderer geeigneter Einsatz (z.B. Zerstörung etc.) nicht möglich war angegeben werden	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Notlageaufgefordert	Nein	Einsatztechnische Daten	Einsatztechnische Daten	D	E	Notlage-Zustand Wertliste siehe Tabellenstat Codes 200		Vorname, Name, ggf. Titel und Funktion des dokumentierenden Personals, wenn möglich, ggf. auch Notlage/Name oder seine Assistenz	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Notlageaufgefordert	Ja	Einsatztechnische Daten	Einsatztechnische Daten	DM	E	Einsatzdatum	NA + RD	Einsatzdatum bezieht sich auf den Zeitpunkt der Alarmierung	Wenn Einsatz vor Einsatz-Pflicht	

DIV-NOTFALLENSATZ-DATENATZESCHREIBUNG 1.1 MIND-DATENATZESCHREIBUNG 1.1 Zusatzfelder in einer Spaltenreihe (z.B. Einzeile) sind ausschließlich für das DIV-Nachkriterienprodukt relevant	Pflicht (gibt an, ob das Feld auf das zugewordene Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugehörigkeit DIV-MIND	Einfach/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	MIND- Teilbereich Nurteil NA Rettungsdienst RD	Erläuterungen	Hinweise/Pflichtsituation/Abhängigkeiten	techn. Detail MIND
Symptombeginn/Verzögerung	siehe Hinweise/ Pfleblätter/ Abhängigkeiten	Ja/Nein/Entfällt	Einzeltechnische Daten	DM	E	Beobachtet die Symptome länger als 24 Stunden oder ist Sie unbekannt? Wertebasis siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Pflicht für NA-Protokolle bei Primäreinsätzen, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR) oder eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen RM handelt. Pflicht für RD-Protokolle bei Primäreinsätzen ohne erkennbare Beteiligung eines physisch anwesenden NA, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR) oder eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen RM handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND EinzeileNA GLEICH (01 ODER 03) UND KeinTranspMSPH NICHT (02 ODER 05 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (11 ODER 13 ODER 14 ODER 15 ODER 16 ODER 17 ODER 18 ODER 19 ODER 98) UND EinzeileNA GLEICH (02 ODER 04) UND Nachrichtungsfortschritt GLEICH 02 UND KeinTranspMSPH NICHT (02 ODER 05 ODER 98)	-2
Symptombeginn	siehe Hinweise/ Pfleblätter/ Abhängigkeiten	Ja/Nein/Entfällt	Einzeltechnische Daten	DM	E	Ereigniszeitpunkt, Unfallzeitpunkt, Kollisionszeitpunkt, Zeitpunkt Symptom-/Beschwerdebegrüßung	NA + RD	Wenn der Symptombeginn bzw. Unfall-/Ereignis-/Kollisionszeitpunkt (bekannt oder geschätzt) innerhalb von 24 Stunden vor Alarmierung liegt, ist die Uhrzeit hier anzugeben.	Pflicht wenn: SymptombeginnVorzeichen GLEICH 05 UND EinzeileNA NICHT (11 ODER 12)	1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Symptombeginn/Geschwindigkeit	siehe Hinweise/ Pfleblätter/ Abhängigkeiten	Ja/Nein/Entfällt	Einzeltechnische Daten	DM	E	ist der Symptombeginn geschätzt oder geschätzt?	NA + RD	08 ist es bekanntes Angaben zum Symptombeginn durch Patienten, Angehörige, Zeugen, etc.?	Pflicht wenn: SymptombeginnVorzeichen GLEICH 02 UND EinzeileNA NICHT (11 ODER 12)	-2
Schüttelbewegung	Nein	Ja/Nein/Entfällt	Einzeltechnische Daten	M	E	Zeitpunkt Eingangs Notfallschüttelung an LST	NA + RD	Pflicht, wenn Symptombeginn innerhalb der letzten 24 Stunden. Definition: Zeitpunkt des Anrufes (Kutschzeitpunkt aus Leitstellen-Datenatz) Wird in der Labelsle dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Alarm	Nein	Ja/Nein/Entfällt	Einzeltechnische Daten	DM	E	Zeitpunkt Alarmfunktionsübergabe	NA + RD	Definition: Auslösung Alarm durch LST Wird in der Labelsle dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Alarmzustand	Nein	Ja/Nein/Entfällt		M	E	Zeitpunkt Alarmfunktions-Status Status 3	NA + RD	Definition: Auslösen des einmündigen Rettungsmittels (Bewertung komplett) Wird in der Labelsle dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Alarm/Ankunft Einsatzort	Nein	Ja/Nein/Entfällt	Einzeltechnische Daten	DM	E	Zeitpunkt Ankunft Einsatzort Status 4	NA + RD	Definition: Ankunft des dokumentierenden RM am Einsatzort. Wird in der Labelsle dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Alarm/Patienten/Patientenkontakt	siehe Hinweise/ Pfleblätter/ Abhängigkeiten	Ja/Nein/Entfällt	Einzeltechnische Daten	DM	E	Zeitpunkt Ankunft Patient	NA + RD	Definition: Ankunft der Rettungsmittelbesatzung beim Patienten bzw. Beginn der Übernahme des Patienten bei Sekundäreinsatz. Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfestellung oder die Unterstützung eines anderen RM handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um einen Krankentransport oder um eine Hilfestellung oder die Unterstützung eines anderen RM handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND KeinTranspMSPH NICHT (05 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND EinzeileNA GLEICH 10 ODER KeinTranspMSPH GLEICH (05 ODER 98)	1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
ZeitTransportbeginn	Nein	Ja/Nein/Entfällt	Einzeltechnische Daten	DM	E	Zeitpunkt Transportbeginn Status 7	NA + RD	Definition: Beginn des Patiententransportes. Wird in der Labelsle dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
ZeitEinfahrenTransportziel	Nein	Ja/Nein/Entfällt	Einzeltechnische Daten	DM	E	Zeitpunkt Eintreffen Transportziel	NA + RD	Definition: Fahrzeug tritt am Transportziel ein Wird in der Labelsle dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
ZeitÜbergabePatient	siehe Hinweise/ Pfleblätter/ Abhängigkeiten	Ja/Nein/Entfällt	Einzeltechnische Daten	DM	E	Übergabe des Patienten an Weiterbehandler	NA + RD	Definition: Übergabe an Personal der Zielklinik/Praxis oder Übergabe an anderes Rettungsmittel (Übergang der Verantwortung für den Patienten). Bei Einsatz ohne Patiententransport optional als Abschluss der Behandlung. Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattgefunden hat (Übergabezeitpunkt an Klinik bzw. an anderes transportierendes RM, wenn dokumentierende NA den Transport nicht begleitet). Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patiententransport durch das dokumentierende RM stattgefunden hat und keine medizinische Begleitung erfolgt bzw. die Begleitung ausschließlich durch einen TNA durchgeführt wurde.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AusreisBegleit ENTHALT (03 ODER 03) UND AusreisBegleit ENTHALT NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 98)	1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
ZeitEinsatzende	Ja	Ja/Nein/Entfällt	Einzeltechnische Daten	DM	E	Zeitpunkt Einsatzende	NA + RD	Definition: Einsatz ist abgeschlossen (RM, aber mit dem Einsatz zusammenhängenden Arbeiten wie z.B. Deaktivationsstätigkeiten und Dokumentation)		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Kapitel: Patientenenden								Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn der Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich beim dokumentierenden Rettungsmittel um einen Krankentransport, eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND KeinTranspMSPH NICHT (05 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND EinzeileNA GLEICH 10 ODER KeinTranspMSPH GLEICH (05 ODER 98)	

DIVANOTFALLEINSAZ: MIND-DATENSATZBESCHREIBUNG 7.1 Datenatzset in einer Spalte (z.B. Einheitsfall) sind ausschließlich für den DIV-Notfallanlassensprozess relevant	Pflicht (bzw. falls bezogen auf das zugehörige Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugehörigkeit DIV-MIND	Einheits-/ Mehrfach EW	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	MIND- Tabelleinstanz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Klinische/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Eingriffskind	Ja			M	E	Einschätzung der zeitlichen Dringlichkeit durch Transportart	NA		Wenn Kapitel "Einschätzung/Vergewissung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	
Indikator T	Ja			M	M	Indikator Interaktivtransport	NA	Siehe Exporthinweise zu Option "Sonstige". Die Antwort NEIN ist implausibel, wenn im Kapitel "Einschätzung/Vergewissung" sowohl eine Bestimmung als auch eine Funktionsfähigkeitsprüfung dokumentiert sind.	Wenn VBestimmung GLEICH 01 UND Katschulanspflicht GLEICH 01, dann ist Code 00 unzulässig. Wenn Kapitel "Einschätzung/Vergewissung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit 00 sind unzulässig.	-2
Kapitel: Diagnosen								Hier für NA-Probleme, wenn der Patientenvermerk abgefragt hat - außer wenn es sich um eine primäre Traumaerkrankung (ohne CPR), eine Verletzung oder eine Unterbrechung eines anderen Rettungsdienstes handelt. Hier für RD-Probleme, wenn der Patientenvermerk abgefragt hat - außer wenn es sich um einen Krankentransport oder eine primäre Traumaerkrankung (ohne CPR), eine Verletzung oder eine Unterbrechung eines anderen Rettungsdienstes handelt oder ein physisch anwesender MA primär dokumentiert oder nachgefragt wurde. Hinweis für RW: Wenn eine Diagnose, für die ein Indikator zur Erfassung der Details oder zur telefonischen Weiterleitung dieser Diagnose existiert, im Diagramm-Feld dokumentiert ist, sind auch eine entsprechend geeignete Details- und telefonische Weiterleitung existiert. Eine unentschiedene Offenbarkeitsangabe sollte im Feld dokumentiert werden.	Hier wenn: Prekliniktyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH 01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 10 UND Katschulanspflicht NICHT 02 ODER 03 ODER 04 ODER Prekliniktyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH 01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 10 UND Katschulanspflicht NICHT 02 ODER 03 ODER 04 ODER 05 UND Katschulanspflicht GLEICH 02 UND Einsatzort GLEICH 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06	
	Ja	Diagnose	Erkrankungen	DM	M	Verlässlichkeitsdiagnose	NA + RD	Hier sollen nur einschlägige Diagnosen und keine Vorerkrankungen dokumentiert werden. Hier sollen nur einschlägige Diagnosen und keine Vorerkrankungen dokumentiert werden. + (Variante: Diagnose der Notrufzeichen, Notrufzeichen bzw. der Notrufzeichen/Notrufzeichen + (Variante: Patienten können mit 1220 + Herz-Kreislauf-Stillstand oder 1913 + SIDS notiert werden. Bei einer Anaphylaxie Grad 4 soll zusätzlich die Diagnose 1220 + Herz-Kreislauf-Stillstand dokumentiert werden. Bei folgenden Verletzungen soll zusätzlich die Diagnose 1220 + Herz-Kreislauf-Stillstand dokumentiert werden. Bis die Offenbarung zwischen hypertonem Notfall (mit Organschäden und Lebensgefahr, z.B. AP, Bauchverletzungen, Lungenödem, neurologische Symptome) und hypertensiver Entgleisung (ohne Organschäden/Lebensgefahr) beurteilt	Wenn Kapitel "Diagnosen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
DiagnoseSonstige_ZNS	Nein		Erkrankungen	D	M	Fest. Zeichenbit 200		Raum zur Erfassung einer im strukturierten Diagnosebereich nicht wählbaren Diagnose aus dem Bereich ZNS-Erkrankungen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
DiagnoseSonstige_Herz-Kreislauf	Nein		Erkrankungen	D	M	Fest. Zeichenbit 200		Raum zur Erfassung einer im strukturierten Diagnosebereich nicht wählbaren Diagnose aus dem Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
DiagnoseSonstige_Atemung	Nein		Erkrankungen	D	M	Fest. Zeichenbit 200		Raum zur Erfassung einer im strukturierten Diagnosebereich nicht wählbaren Diagnose aus dem Bereich Atemungsorgane	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
DiagnoseSonstige_Abdomen	Nein		Erkrankungen	D	M	Fest. Zeichenbit 200		Raum zur Erfassung einer im strukturierten Diagnosebereich nicht wählbaren Diagnose aus dem Bereich abdominale Erkrankungen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
DiagnoseSonstige_Psychische	Nein		Erkrankungen	D	M	Fest. Zeichenbit 200		Raum zur Erfassung einer im strukturierten Diagnosebereich nicht wählbaren Diagnose aus dem Bereich psychische Erkrankungen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
DiagnoseSonstige_Stoffwechsel	Nein		Erkrankungen	D	M	Fest. Zeichenbit 200		Raum zur Erfassung einer im strukturierten Diagnosebereich nicht wählbaren Diagnose aus dem Bereich stoffwechsel Erkrankungen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
DiagnoseSonstige_Pedunkle	Nein		Erkrankungen	D	M	Fest. Zeichenbit 200		Raum zur Erfassung einer im strukturierten Diagnosebereich nicht wählbaren Diagnose aus dem Bereich pedunkle Erkrankungen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
DiagnoseSonstige_Kyrenologische	Nein		Erkrankungen	D	M	Fest. Zeichenbit 200		Raum zur Erfassung einer im strukturierten Diagnosebereich nicht wählbaren Diagnose aus dem Bereich kyrenologische Erkrankungen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
DiagnoseSonstige_Sonstige	Nein		Erkrankungen	D	M	Fest. Zeichenbit 200		Raum zur Erfassung einer im strukturierten Diagnosebereich nicht wählbaren Diagnose aus dem Bereich sonstige Erkrankungen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Hemiparesis	Nein		Erkrankungen	D	E	Verweise siehe Tabellenblatt Codes 2001		Ja = Hemiparesis verfügbar bzw. genutzt, Nein = keine Hemiparesis verfügbar bzw. genutzt, leer = unbekannt	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Hemiparesis	Nein		Erkrankungen	D	E	Verweise siehe Tabellenblatt Codes 2001		Ja = Hemiparesis verfügbar bzw. genutzt, Nein = keine Hemiparesis verfügbar bzw. genutzt, leer = unbekannt	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Diagnose	Nein		Erkrankungen	D	E	Verweise siehe Tabellenblatt Codes 2001		Raum für die Verlässlichkeit der Diagnose und Symptome	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Kapitel: Verletzungen/Details										
Verletzungen/Details	Ja	Verletzungen/Details	Verletzungen	DM	E	Verletzungen/Details	NA + RD	Polysymptom: Gleichzeitige entstandene Verletzungen mehrerer Körperregionen oder Organsysteme, wobei wenigstens eine Verletzung oder die Kombination mehrerer lebensbedrohlich ist.	Wenn Kapitel "Verletzungen/Details" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
Verletzungen/Details	Ja	Verletzungen/Details	Verletzungen	DM	E	Verletzungen/Details	NA + RD		Wenn Kapitel "Verletzungen/Details" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
Verletzungen/Details	Ja	Verletzungen/Details	Verletzungen	DM	M	Verletzungen/Details	NA + RD		Kombinationen mit 00 sind unzulässig	-2
Verletzungen/Details	Ja	Verletzungen/Details	Verletzungen	DM	M	Verletzungen/Details	NA + RD		Wenn Kapitel "Verletzungen/Details" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
Verletzungen/Details	Nein	Verletzungen/Details	Verletzungen	DM	E	Verletzungen/Details	NA + RD	Hier der/die Verursacher zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm getragen?	Kombinationen mit 00 sind unzulässig.	-2
Verletzungen/Details	Nein	Verletzungen/Details	Verletzungen	D	M	Verweise siehe Tabellenblatt Codes 2001		Verweise, ob und ggf. wo verletzende Verletzungen vorliegen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Verletzungen/Details	Nein	Verletzungen/Details	Verletzungen	D	M	Verweise siehe Tabellenblatt Codes 2001		Verweise, ob und ggf. wo instabile Verletzungen vorliegen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Verletzungen/Details	Nein	Verletzungen/Details	Verletzungen	D	M	Verweise siehe Tabellenblatt Codes 2001		Verweise, ob und ggf. wo traumatische Schocks vorliegen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Verletzungen/Details	Nein	Verletzungen/Details	Verletzungen	D	M	Verweise siehe Tabellenblatt Codes 2001		Verweise, ob und ggf. wo Kopfverletzungen vorliegen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Verletzungen/Details	Nein	Verletzungen/Details	Verletzungen	D	E	Verweise siehe Tabellenblatt Codes 2001		Verweise zum Unfallhergang	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Verletzungen/Details	Nein	Verletzungen/Details	Verletzungen	D	E	Verweise siehe Tabellenblatt Codes 2001		Raum zur Erfassung einer bei den strukturierten Verletzungen nicht wählbaren "sonstigen" Verletzung	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Verletzungen/Details	Nein	Verletzungen/Details	Verletzungen	D	E	Verweise siehe Tabellenblatt Codes 2001		Raum zur Erfassung einer bei den strukturierten Verletzungen nicht wählbaren "sonstigen" Verletzung	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	

DIV-HOTFALLEINSAZ: DATENSATZSCHREIBUNG 1.1 WIND-DATENSATZSCHREIBUNG 1.1 Zusammenhang in einer Situation (z.B. Einsatz) sind ausschließlich für das DIV-Kriterienkriterium relevant	Pflicht (je falls bezogen auf das zugehörige Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugehörigkeit DIV-MIND	Einfach/ Mehrfach E/M	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	MIND- Teilsatz Notiert NA Rettungsdienst RD	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Status MIND
Reanimationssituation	Ja	Reanimation	Reanimation	M	E	Wurde eine Reanimation durchgeführt? Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Eine dokumentierte Reanimation ist mit E1 oder E2 oder E3 zu dokumentieren. Bei primärer Todesbestätigung (ohne CPR) ist nur "Reanimation nicht durchgeführt." zulässig. Ohne Patientenkontakt ist nur "keine Reanimationssituation (kein Totkriterien-Kriterienfeld)" zulässig. Bei Diagnose Herz-Kreislauf-S Stillstand oder SIDS bzw. bei Dokumentation "Patient im Ersatzzeitpunkt verstorben" ist "keine Reanimationssituation (kein Totkriterien-Kriterienfeld)" unzulässig.	Hinweise für Dokumentationsanforderung und Plausibilitätsprüfungen Wenn KeinTranspMPut GLEICH 02, dann ist Reanimationssituation GLEICH 00 ODER 01 ODER 02 ODER 03 ODER 04 unzulässig. Wenn RDTransport GLEICH 02, dann ist nur Reanimationssituation GLEICH 00 zulässig. Wenn Diagnose ENTHALT (1200 ODER 1813) ODER KeinTranspMPut GLEICH 03 dann ist Reanimationssituation GLEICH 00 unzulässig.	-2
Kapitel: ReanimationDetails								Pflicht für NA-Protokolle, wenn dokumentierendes Rettungsdienst Reanimation durchgeführt hat und eine Notfallübung ohne erkennbare NA-Beteiligung bzw. Nachforderung vorliegt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn dokumentierendes Rettungsdienst Reanimation durchgeführt hat und eine Notfallübung ohne erkennbare NA-Beteiligung bzw. Nachforderung vorliegt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimationssituation GLEICH 01 ODER 02 ODER 03) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimationssituation GLEICH 01 ODER 02 ODER 03) UND Einsetzen GLEICH 02 ODER 04 ODER 06 ODER 08) UND Nachforderung GLEICH 02	
Reanimationstechnik	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	M	Verfährte siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD		Wenn Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
UNREST	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Vermutete Ursache des Kreislaufstillstandes Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Die internationalen Vorgaben des Utstein-Styls Protokolle unterscheiden die Ursachen eines Kreislaufstillstandes in mehreren Sektionen. Gehört ist die aus Sicht des Notarztes vermutete Ursache.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
SPORT	Nein	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Zusammenhang mit sportlicher Aktivität Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Beschreibt ein Zusammenhang des Kreislaufstillstandes mit sportlicher Aktivität?	Wenn Reanimationssituation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
DOFR	Nein	ReanimationDetails	Notfallgeräten	DM	E	Zeitpunkt Einsetzen First Responder Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Eintrittszeit eines First Responders als "Einschussvorgang" neben dem regulären Rettungsdienst am Einsatzort.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-03-02T22:00:00.000+01:00
EXIS	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Person Kolaps beobachtet? Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Wer hat den Kolaps beobachtet? Eventuell entspricht dem nichtmedizinischen Personal bzw. Laien.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
DOEM	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Person Herzdruckmassage begonnen Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Wer hat mit der Herzdruckmassage begonnen bzw. den Beginn angeordnet? (Es ist die jeweils am höchsten qualifizierte anwesende Person zu dokumentieren)	Wenn Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann ist 06 unzulässig. Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind 05 ODER 06 unzulässig. Wenn Reanimationssituation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
DOEF1	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Person Defibrillation durchgeführt Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Wer hat die erste Defibrillation durchgeführt bzw. angeordnet? (Es ist die jeweils am höchsten qualifizierte anwesende Person zu kodieren.)	Wenn Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann ist 06 unzulässig. Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind 05 ODER 06 unzulässig. Wenn Reanimationssituation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
DOEM	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Zeitpunkt Beginn Herzdruckmassage Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Erster Zeitpunkt, zu dem mit der Herzdruckmassage begonnen wurde, ggf. schätzen.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-03-02T22:00:00.000+01:00
DOEF1	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Zeitpunkt erste Defibrillation Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Zeitpunkt der ersten Defibrillation. Pflicht für NA-Protokolle, wenn eine Defibrillation durch den KTW, RTW oder NA dokumentiert wurde. Pflicht für RD-Protokolle, wenn eine Defibrillation durch den KTW oder RTW dokumentiert wurde und eine Notfallübung ohne erkennbare NA-Beteiligung bzw. Nachforderung vorliegt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND DOEF1 GLEICH 04 ODER 05 ODER 06) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND DOEF1 GLEICH 04 ODER 05) UND Einsetzen GLEICH 02 ODER 04 ODER 06 ODER 08) UND Nachforderung GLEICH 02 Wenn Reanimationssituation GLEICH 05, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-03-02T22:00:00.000+01:00
DOESC1	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Zeitpunkt 1. ROSC Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Bei Wiederertritt eines Eigenkreislaufs (ROSC) ist die Zeit zu notieren. Ab diesem Zeitpunkt hat der Patient einen eigenen Kreislauf mit einem messbaren Puls. Auch wenn dieser wieder zusammenbricht (ROSC = nicht 4. spontaneus stabilisiert (Spontankreislauf)).	Pflicht wenn: ROSC GLEICH 02 Wenn Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-03-02T22:00:00.000+01:00
ROSC	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Erreichen eines Spontankreislaufs Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Konnte durch die Reanimationsmaßnahmen jemals ein spontaner Kreislauf > 30 Sekunden etabliert werden? Wenn bei Feld KHALF "Krankheitsaufnahme mit ROSC", dann in Feld ROSC nur "jenseits ROSC" zulässig.	Wenn KHALF GLEICH 02, dann nur ROSC GLEICH 03 zulässig. Wenn Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
KHALF	Ja	ReanimationDetails	Reanimation	DM	E	Patientenzustand bei Krankentransportaufnahme Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Zustand bei Übergabe an die Zielklinik.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
TDO	Nein	ReanimationDetails	Reanimation	DM	E	Zeitpunkt TDO Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Bewertungszustandpunkt der Reanimationsmaßnahmen.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-03-02T22:00:00.000+01:00
ReanimationErfolg	Nein	Massnahmen	D	E	Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes 2001		Wertefeld 0 und mit welchem Erfolg eine Reanimation erfolgte	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		
ReanimationFeedback	Nein	Massnahmen	D	E	Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes 2001		Ja = Ein Feedbacksystem wurde eingesetzt, Nein = Es wurde kein Feedbacksystem eingesetzt, Leer = wie Nein	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		
ReanimationTafeln	Nein	Massnahmen	D	E	Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes 2001		Ja = Tafelreanimation wurde eingesetzt, Nein = Tafelreanimation wurde nicht eingesetzt, Leer = wie Nein	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		
ReanimationBefehl	Nein	Massnahmen	D	E	Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes 2001		Wertefeld, wenn eine Reanimation bei reanimationsfähigen Patienten nicht eingesetzt wurde	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		
ReanimationHautSonstige	Nein	Massnahmen	D	E	Text_Zusatztext 200		Text warum eine Reanimation bei reanimationsfähigen Patienten nicht eingesetzt wurde, wenn Wert in zugehöriger Wertefeld nicht enthalten ist	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		

DIV-NOTFALLDATENSATZ: DATENSATZSCHRIBUNG 1.1 MIND-DATENSATZSCHRIBUNG 1.1 Datenfelder in einer Schriftprobe (z.B. Einzelblätter einer Leichenschaukarte für das DIV-Mortalfahrzeugprotokoll) relevant	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugehörigkeit DIV-MIND	Einfach-/ Mehrfach EW	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	MIND- Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitätsabhängigkeiten	techn. Default MIND
ZusatzSonstige	Nein		Reanimation	D	E	Text_Zeichenbit 200		Vermutete Ursache des Kreislaufstillstands, wenn in der zugehörigen Webliste nicht angegeben	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
KollegenBedachtlosSonstige	Nein		Reanimation	D	E	Text_Zeichenbit 200		Angabe zur Person, die den Kollegen bedachtlos hat, wenn in den zugehörigen Feldern nicht aufgeführt	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
ReanimGefährliche	Nein		Reanimation	D	E	Text_Zeichenbit 200		Angabe zur Person, die mit der Reanimation begonnen hat, wenn in den zugehörigen Feldern nicht aufgeführt	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
ReanimGefährliche	Nein		Reanimation	D	E	Text_Zeichenbit 200		Angabe zur Person, die die erste Defibrillation durchgeführt hat, wenn in den zugehörigen Feldern nicht aufgeführt	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
TodesUrs	Nein		Reanimation	D	M	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes DIV1		Werteliste zu Todeszeitpunkt und Ort des Todes	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
TodesUrs	Nein		Reanimation	D	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes DIV1		Werteliste zur Todesursache	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
TodesUrs	Nein		Reanimation	D	E	Angabe von Datum und Uhrzeit		Kalender: das Todes Ereignis (Freigabe durch Arzt der die ggf. vollständige oder endgültige Leichenschau macht)	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
NA										

6. Codes DIVI

DIVI Notfalleinsatzprotokoll 7.1 Werteliste	Release 1: 28.08.2026
Werteliste	
Fehleinsatz -1 = kein Fehleinsatz 01 = kein Patient 02 = Pat. bereits abtransportiert 03 = abbestellt 04 = böswillige Alarmierung 05 = Einsatzabbruch technisch 06 = Einsatzabbruch Wetter 99 = Einsatzabbruch Sonstige	
Versorgungssituation -1 = nicht bekannt 01 = unabhängig 02 = Pflege zuhause 03 = Pflege in Institution	
Antikoagulanzen vor dem Notfallereignis -1 = nicht bekannt 01 = TZ-Aggregationshemmer 02 = Vit.K Antagonist 03 = Heparin(oide) 04 = DOAK Thrombinhemmer 05 = DOAK Xa-Hemmer 99 = Sonstige bzw. unklar welche	
Ersthelfermaßnahmen -1 = nicht bekannt 01 = suffizient 02 = insuffizient 03 = Keine	
Vitale Probleme nach ABCDE -1 = nicht erfasst 01 = A 02 = B 03 = C 04 = D 05 = E	
Augen öffnen -1 = nicht untersucht 00 = nicht vorhanden 01 = auf Druck 02 = auf Geräusch 03 = Spontan 99 = nicht beurteilbar	
Beste verbale Reaktion -1 = nicht untersucht 00 = keine 01 = Laute 02 = Wörter 03 = Kversationsfähig verwirrt 04 = Kversationsfähig orientiert 99 = nicht beurteilbar	

Beste motorische Reaktion

-1 = nicht untersucht

00 = keine

01 = Streckt

02 = Beugt abnormal

03 = Beugt normal

04 = lokalisiert

05 = folgt Aufforderung

99 = nicht beurteilbar

Beste motorische Reaktion

-1 = nicht untersucht

00 = keine

01 = Streckt

02 = Beugt abnormal

03 = Beugt normal

04 = lokalisiert

05 = folgt Aufforderung

99 = nicht beurteilbar

Beste motorische Reaktion

-1 = nicht untersucht

00 = keine

01 = Streckt

02 = Beugt abnormal

03 = Beugt normal

04 = lokalisiert

05 = folgt Aufforderung

99 = nicht beurteilbar

Beste motorische Reaktion

-1 = nicht untersucht

00 = keine

01 = Streckt

02 = Beugt abnormal

03 = Beugt normal

04 = lokalisiert

05 = folgt Aufforderung

99 = nicht beurteilbar

Extremitätenbewegung

-1 = nicht untersucht

00 = keine Bewegung

01 = kein Anheben

02 = einseitiges Absinken

99 = nicht beurteilbar

Extremitätenbewegung

-1 = nicht untersucht

00 = keine Bewegung

01 = kein Anheben

02 = einseitiges Absinken

99 = nicht beurteilbar

Extremitätenbewegung

-1 = nicht untersucht

00 = keine Bewegung

01 = kein Anheben

02 = einseitiges Absinken

99 = nicht beurteilbar

Extremitätenbewegung

-1 = nicht untersucht
 00 = keine Bewegung
 01 = kein Anheben
 02 = einseitiges Absinken
 99 = nicht beurteilbar

Pupillenweite rechts

-1 = nicht untersucht
 00 = keine
 01 = eng
 02 = mittel
 03 = weit
 04 = entrundet
 99 = nicht beurteilbar

Pupillenweite links

-1 = nicht untersucht
 00 = keine
 01 = eng
 02 = mittel
 03 = weit
 04 = entrundet
 99 = nicht beurteilbar

Lichtreaktion rechts

-1 = nicht untersucht
 00 = keine
 01 = träge
 02 = prompt
 99 = nicht beurteilbar

Lichtreaktion links

-1 = nicht untersucht
 00 = keine
 01 = träge
 02 = prompt
 99 = nicht beurteilbar

Diastolischer Blutdruck

Messwert in mmHg
Wertebereich = 0 - 250
 -1 = nicht gemessen
 999 = nicht messbar

qSOFA-Score

Wertebereich = 00 bis 03
 99 = nicht errechenbar

NEWS2-Score

Wertebereich = 00 bis 20
 99 = nicht errechenbar

Penetrierende Verletzung

-1 = nicht untersucht
 00 = keine
 01 = Kopf, Gesicht, Hals
 02 = Thorax
 03 = Abdomen
 99 = nicht beurteilbar

Instabile Verletzung

-1 = nicht untersucht
 00 = keine
 01 = Thorax
 02 = Becken
 99 = nicht beurteilbar

Sensomotorisches Defizit

-1 = nicht untersucht

00 = keine

01 = HWS

02 = BWS, LWS

99 = nicht beurteilbar

Amputation

-1 = nicht untersucht

00 = keine

01 = Arm

02 = Bein

99 = nicht beurteilbar

Unfallart

01 = Fraktur von ≥ 2 gr. Röhrenknochen

02 = Verätzung

03 = Einklemmung

04 = Inhalationstrauma

05 = Elektrounfall

06 = (Beinahe-)Ertrinken

07 = Tauchunfall

08 = Hochrasanztrauma

Airway Maßnahmen²

-1 = keine Maßnahmen durchgeführt

01 = mechanisches Freimachen/Freihalten der Atemwege

02 = Absaugen

03 = Präoxygenieren

04 = Wendl-Tubus

05 = Guedel-Tubus

06 = Larynxmaske

07 = Larynxtubus

08 = Endotracheale Intubation oral

09 = Endotracheale Intubation nasal

98 = Sonstige

Circulation Zugang²

-1 = keine Maßnahmen durchgeführt

01 = PVK vorhanden

02 = ZVK vorhanden

03 = IO vorhanden

04 = Transnasal-Applikator

Zugang Art

01 = PVK

02 = ZVK

03 = intraossär

04 = arteriell

98 = Sonstige

Zugang Ort

- 01 = Handrücken
- 02 = Unterarm
- 03 = Ellenbeuge
- 04 = Oberarm
- 05 = Hals
- 06 = Kopf
- 07 = Bein
- 08 = Fuss
- 09= V. basilica/cephalica
- 10 = V. subclavia
- 11 = V. jugularis int.
- 12 = V. jugularis ext.
- 13 = V. femoralis
- 14 = Tibia proximal
- 15 = Tibia distal
- 16 = Humerus proximal
- 17 = Sternum
- 18 = A. radialis
- 19 = A. femoralis
- 98 = Sonstige

Zugang Seite

- 01 = links
- 02 = rechts
- 03 = keine Seite
- 97 = unbekannt

Zugang Größe

- 01 = 24G
- 02 = 22G
- 03 = 20G
- 04 = 18G
- 05 = 18G kurz
- 06 = 17G
- 07 = 16G
- 08 = 14G
- 09= 15mm
- 10 = 25mm
- 11 = 45mm
- 98 = Sonstige

Zugang erschwert

- 01 = Zugang erschwert
- 02 = mehr als 2 Versuche
- 03 = unmöglich - Verfahrenswechsel

Beatmung

- 1 = keine Maßnahmen durchgeführt
- 01 = Manuell
- 02 = Maschinell kontrolliert
- 03 = Maschinell assistiert
- 04 = NIV

Defi Geräteart

- 01 = Defibrillation
- 02 = Kardioversion
- 03 = Defi
- 04 = AED
- 05 = publicAED

Defischock Energie

Wertebereich

gültiger Wertebereich = 10 bis 500 Joule

weitere Massnahmen

01 = Impella

02 = IABP

03 = ECMO

04 = Thoraxdrainage rechts

05 = Thoraxdrainage links

06 = Entlastungspunktion rechts

07 = Entlastungspunktion links

08 = Thorakotomie

09 = Thoraxverschlusspflaster

10 = Magensonde

11 = Blasenkatheter

12 = besondere Hygienemaßnahmen

Ersthelfermaßnahmen

-1 = keine Lyse

01 = Lyse vor Kreislaufstillstand

02 = Lyse während Kreislaufstillstand

03 = Lyse nach ROSC

99 = Lysezeitpunkt nicht bekannt

Neurologie Verlauf

-1 = nicht untersucht

01 = unverändert

02 = neu erhoben

Anmeldung wo

-1 = keine Anmeldung

01 = Stroke Unit

02 = Herzkatheter

03 = Traumazentrum

04 = Schockraum

99 = Sonstige benötigte Ressource

Reanimation Ja

01 = Reanimation erfolgt

02 = ROSC im Verlauf

03 = niemals ROSC

04 = erfolglos

Reanimation Nein

01 = Patientenverfügung

02 = zu spät

03 = aussichtslose Grunderkrankung

04 = Reanimation im Vorfeld erfolgreich

05 = Sonstige

Tod Info

01 = vor Ort

02 = auf dem Transport

03 = Zeitpunkt bestimmbar

04 = Zeitpunkt nicht bestimmbar

Todesart

01 = natürlich

02 = unklar

03 = nicht natürlich

der Kollaps wurde beobachtet

01 = Ja

02 = Nein

die Ankunft des notarztbesetzten Rettungsmittels erfolgte vor dem RTW

01 = Ja

02 = Nein

der Patientenname ist unbekannt und Pseudonym eingesetzt

01 = Ja

02 = Nein

das Geburtsdatum wurde geschätzt

01 = Ja

02 = Nein

der BMI liegt unter 40

01 = Ja

02 = Nein

der Patient ist dialysepflichtig

01 = Ja

02 = Nein

der Patient ist infektiös

01 = Ja

02 = Nein

die Sauerstoffsättigung wurde bei Raumluft gemessen

01 = Ja

02 = Nein

die Herzaktion ist rhythmisch

01 = Ja

02 = Nein

Heimbeatmung ist verfügbar oder wurde genutzt

01 = Ja

02 = Nein

Heimsauerstoff ist verfügbar oder wurde genutzt

01 = Ja

02 = Nein

die Patientenübergabe wurde verzögert

01 = Ja

02 = Nein

ein Feedbacksystem wurde eingesetzt

01 = Ja

02 = Nein

eine Telefonreanimation wurde durchgeführt

01 = Ja

02 = Nein